

Sémiologie et étude de cas

Livret d'accompagnement du CM

Bachelor 2 Psychologie

PHILIPPE SPOLJAR

Courriel : philippe.spoljar@u-picardie.fr

1. Signes et symptômes

1.1. La structure théorique du symptôme

La définition de formes typiques de maladies, syndromes et structures, d'après :

- les symptômes et les signes (*sémiologie*)
- les causes (*étiologie*)
- les modes de formation (*pathogénie*)
- les significations

Les particularités de l'examen clinique en psychopathologie :

« Sur le plan sémiologique, l'examen psychiatrique est caractérisé par une multitude d'obstacles, de pièges, de difficultés en tous genre : des symptômes cachés par d'autres symptômes psychiques, des symptômes prenant le masque organique, l'expression bruyante de symptômes mineurs, la discrétion de symptômes majeurs, la possible réticence du patient, et l'absence de symptômes pathognomoniques. »
(S. Tribolet, M. Shahidi, *Nouveau précis de sémiologie des troubles psychiques*, 2005, p. XVI).

Point de départ : l'appréhension des symptômes

Cadre de l'analyse :

- 1/ Décrire (signe/symptôme/syndrome/tableau).
- 2/ Classer (nosographie/nosologie).
- 3/ Comprendre/interpréter

1.2.1.1. Du côté du sujet : les symptômes

« Le symptôme est un langage qu'il faut entendre » (S. Tribolet, M. Shahidi, *Nouveau précis de sémiologie des troubles psychiques*, 2005, p. XIX)

Le symptôme est du côté du sujet, c'est ce dont il se plaint

C'est un phénomène complexe : le reflet extérieur d'un phénomène interne

Dans une approche compréhensive, le symptôme est considéré comme ce qui constitue la "demande" du sujet. Il faut examiner :

- le contenu symptomatique
- éventuellement les termes de sa genèse
- les significations attribuées *par le patient* à ce qui fait symptôme
- la manière dont le symptôme se manifeste dans la vie du patient et son histoire
- les mots utilisés pour l'évoquer

Le symptôme cache et manifeste en même temps. Il s'agit donc de comprendre :

- le "message" dont il est porteur
- ses effets
- les raisons de son apparition

Il correspond à la manifestation "d'autre chose" : le symptôme a une valeur symbolique et/ou indicielle, aussi bien au niveau organique que psychique

La dimension intersubjective est essentielle : le symptôme est "adressé"

1.2.1.2. Du côté de l'observateur : les signes et syndromes

« Si le diagnostic a un sens en psychiatrie, c'est avant tout, selon nous, comme aide pour mieux reconnaître, mieux voir, mieux entendre le signe que nous fait le patient dans sa souffrance. Un signe que le patient lui-même, le plus souvent, ne perçoit pas ou ne déchiffre pas. Ainsi le soin psychiatrique ne consiste pas à traiter un diagnostic mais à répondre à un symptôme ou une situation. » (S. Tribolet, M. Shahidi, Nouveau précis de sémiologie des troubles psychiques, Editions Heures de France, 2005, p. XIX)

Le signe résulte de la transformation du symptôme, prenant place dans une sémiologie, dans le cadre d'une nosographie

Le travail sémiologique : traduire les symptômes en signes

Ambiguïté terminologique :

- soit : le symptôme est la part subjective du signe
- soit : les deux termes sont équivalents

1.2.1.3. Signe et sémiologie

Un signe n'existe jamais seul ; un signe isolé n'a aucune valeur diagnostique :

- seul un ensemble de signes a une signification
- les signes peuvent se manifester hors structure psychopathologique
- un même signe peut appartenir à plusieurs tableaux (cf. infra la question transnosographique)
- il n'y a pas de signes pathognomoniques

Etude sémiologique : recueil et organisation de l'ensemble des signes présents dans une situation clinique

Le travail d'analyse sémiologique consiste à caractériser des signes

L'absence d'un signe (ou l'absence d'une représentation dans le discours du patient) peut être importante

1.2. Le statut du symptôme dans les différentes psychopathologies

Le statut du signe varie selon les différentes orientations en psychopathologie.

1.2.2.1. Les "dys-" : l'hyper-, l'hypo- et le para-

La perspective de la variation autour de la norme

1.2.2.2. L'exemple de la phobie

Le statut de la phobie change totalement selon la psychopathologie sous-jacente :

- approche *psychanalytique* : la phobie a une valeur symbolique, elle est la résultante de processus psychiques dynamiques (déplacement)
- approche *systémique* : la phobie révèle une disposition familiale pathologique dont elle constitue le symptôme
- approche *comportementale* : la phobie résulte d'un mauvais conditionnement

- approche *psychiatrique* : elle consiste en une angoisse excessive qu'il s'agit de dissoudre par anxiolytique
- approche *phénoménologique* : une phobie est l'actualisation particulière d'une angoisse existentielle humaine

1.3. Méthodologie de l'étude de cas (Mme V., 40 ans)

Premières phases d'une étude de cas (à partir d'une observation ou d'un entretien) :

1. Lecture/écoute linéaire et relevé sémiologique
2. Regroupement des signes par catégories
3. Proposition d'un diagnostic (psychiatrique)

Mme V., 40 ans, est hospitalisée en service de médecine, pour fatigue et amaigrissement. Les examens somatiques ne montrent aucune anomalie. Il est demandé au psychiatre de la rencontrer. Son discours est assez pauvre, monotone, le débit est lent. Elle se plaint de ne plus avoir de force, de n'avoir envie de rien, d'être opprimée : « *je ne dors plus, toutes les nuits je me réveille, pourtant je suis fatiguée, je ne fais rien, je ne suis capable de rien, je suis tout le temps triste* ». Elle dit elle-même qu'elle n'a plus faim, qu'elle pense ne pas pouvoir aller mieux et qu'elle se sent abandonnée. A plusieurs reprises, elle pleure au cours de l'entretien et dit qu'elle a peur de mourir. Le reste du temps, son visage exprime la tristesse. Il n'existe ni antécédents familiaux, ni antécédents personnels. *Aucun événement marquant* n'a pu être relevé dans les mois précédents l'apparition de son état qui dure depuis environ 5 semaines.

Le recueil et le regroupement des signes indiquent :

- *Troubles de l'humeur* :

Symptômes (données cliniques) >	Signes
"elle ne pense pas pouvoir aller mieux"	Pessimisme
"je suis tout le temps triste" ; "son visage exprime la tristesse"	Tristesse
"elle pleure au cours de l'entretien"	Pleurs
"elle se plaint [...] de n'avoir envie de rien"	Perte des intérêts
"je ne suis capable de rien" ; "je n'arrive pas..."	Idées d'incapacité, dévalorisation de soi

- *Activité psychomotrice* :

Symptômes (données cliniques) >	Signes
"elle est hospitalisée pour fatigue"	Fatigue
"elle se plaint de ne plus avoir de forces"	Asthénie
"je ne fais rien"	Apathie
"son discours est assez pauvre, monotone", débit lent	Bradypsychie

- *Troubles des conduites* :

Symptômes (données cliniques)	Signes
"elle n'a pas faim", amaigrissement	Anorexie
"je ne dors plus, toutes les nuits je me réveille"	Insomnies (milieu de nuit)

- *Peur et angoisse* :

Symptômes (données cliniques)	Signes
<i>"Elle se plaint [...] d'être opprimée"</i>	Sentiment d'oppression
<i>"elle se sent abandonnée"</i>	Angoisse d'abandon
<i>"elle a peur de mourir"</i>	Angoisse de mort (idées suicidaires ?)
<i>"toutes les nuits je me réveille"</i>	Angoisses nocturnes, cauchemars ?

2. Les principaux signes cliniques

2.1. La pensée

a) Le jugement et le raisonnement

- le *rationalisme morbide* : raisonnements poussés jusqu'à l'absurde
- l'*incohérence* : illogisme, absurdité
- la *fausseté du jugement* : erreurs de jugement déterminées par des affects puissants
- l'*interprétation* : attribution de significations erronées

b) Le cours de la pensée

- la *tachypsychie* / *fuite des idées* : accélération de tous les processus psychiques, notamment de la pensée.
- la *bradypsychie* : ralentissement de la pensée et mono-idéisme.
- les *troubles de la synthèse mentale* : difficulté à organiser la pensée et confusion mentale.
- la *discontinuité* de la pensée : interruption du cours de la pensée ("barrage"/"fading")

c) Le contenu de la pensée

- les *troubles imaginatifs* : expansion de l'activité imaginative (mythomanie, fabulation...)
- les *idées fixes* ou *idées prévalentes* : mobilisation totale de la pensée
- les obsessions : représentations qui s'imposent au sujet qui reconnaît leur caractère pathologique
 - . les obsessions *idéatives* : pensées obsédantes, compulsives
 - . les obsessions *phobiques* : angoisses phobiques en l'absence de l'objet
 - . les obsessions *impulsives* : peur de commettre un acte incontrôlé
- les *distorsions globales* de la pensée :
 - . la pensée *autistique* : enfermement dans ses pensées
 - . l'*hermétisme* : pensées opaques
 - . la pensée *déréelle* : pensée sans ancrage dans la réalité
 - . la pensée *magique* : croyance aux pouvoirs de la pensée sur la matière
 - . la pensée *paralogique* : raisonnement d'apparence logique, dont les prémisses sont fausses
- . l'*automatisme mental* (syndrome de Clérambault) :
 - 1. syndrome d'influence : pensée imposée, entravée, contrôlée de l'extérieur
 - 2. hallucinations psychiques : voix intérieures, vol et devinement de pensée

d) Les idées délirantes

Croyance en une idée erronée, en opposition avec la réalité ou le sens commun du groupe socio-culturel

1/ Thèmes

- idées de *grandeur* (*mégalomanie*)
- idées d'*érotomanie*
- idées de *jalousie*
- idées de *persécution*
- idées de *quérulence*
- idées de *négation* (*négativisme*)
- idées d'*influence*
- idées de *référence*
- idées *mystiques*
- idées d'*indignité*
- idées de *filiation*

2/ Mécanismes

- l'*intuition*
- l'*imagination*
- l'*illusion*
- l'*interprétation*
- l'*hallucination*

3/ Degré de systématisation

- *systématisé* : développement ordonné, d'apparence "cohérente"
- *polymorphe* : multiplicité de thèmes et de mécanismes

4/ Extension

- en *secteur* : ne concerne qu'un domaine circonscrit
- en *réseau* : extension graduelle à toute la vie du sujet

5/ Acuité ou chronicité

- *aigu* : épisodes critiques
- *chronique* : présence permanente

6/ Degré de conviction

Rapport du sujet à son délire : conviction, certitude ...

2.2. L'humeur et les émotions

a) L'expression des émotions

- l'*hyperémotivité* : réaction émotionnelle excessive
- la *froideur affective* / *ataraxie* : absence d'expression
- la *labilité émotionnelle* : variabilité des manifestations émotionnelles
- l'*inhibition* : blocage ou affaiblissement d'une fonction psychique
- l'*alexithymie* : difficulté à identifier/exprimer ses émotions
- la *discordance* : inadéquation entre le discours et les émotions exprimées
- les *réactions critiques* : colère, crises, tension chronique ...

b) Les troubles de l'humeur

- la *dysthymie* : tristesse pathologique
- l'*anhédonie* : perte de plaisir
- la *perte d'intérêt* (pour soi, pour le monde)
- le *sentiment d'absence d'avenir*
- le *sentiment d'incurabilité*
- l'*euphorie* : joie démesurée
- l'*athymie* : indifférence thymique {voir froideur affective}
- la *cyclothymie* : alternances brusques d'humeur, d'allure périodique

c) La peur et l'angoisse, les phobies

- l'*angoisse* : une sensation d'oppression et d'étouffement
- la *peur* : crainte devant un danger externe
- l'*anxiété* : appréhension d'un danger imminent
- la *phobie* : angoisse suscitée par un objet ou une représentation spécifique
 - la *nosophobie* : crainte des contaminations
 - la *mysophobie* : peur d'être en contact avec la souillure
 - l'*agoraphobie* : crainte des espaces ouverts
 - la *claustrophobie* : crainte des espaces fermés
 - l'*acrophobie* : peur des hauteurs
 - la *misophonie* : aversion pour certains bruits
 - la *sitiophobie* : peur d'être empoisonné par la nourriture
 - la *phagophobie* : crainte de s'étouffer en avalant
 - la *phobie scolaire* : aversion pour l'école
 - la *phobie sociale* : peur du regard des autres
 - l'*oikophobie* : aversion pour sa famille, maison, milieu ou culture

- la *dysmorphophobie* : crainte concernant une déformation physique

2.3. La perception

a) Les illusions

Déformation de la perception d'un objet réel

b) Les hallucinations

Perception d'objets qui n'existent pas dans la réalité extérieure

1/ Les hallucinations psycho-sensorielles

- Les hallucinations *psycho-sensorielles* ont la qualité d'une perception normale : auditive, visuelles, olfactives, gustatives et tactiles
- Les hallucinations *cénesthésiques* concernent la sensibilité proprioceptive et intéroceptive

2/ Les hallucinations psychiques

Les hallucinations *psychiques* correspondent au vécu d'une intrusion dans la vie psychique (cf. automatisme mental)

c) La conscience de soi

- le *trouble du schéma corporel* : illusions de déformations relatives au corps
- l'*altération de l'image du corps* : impression de changement de forme du corps
- le *signe du miroir* : examen long et fréquent de soi (essentiellement le visage) dans un miroir
- la *dépersonnalisation* : sentiment de désincarnation, de détachement de soi

2.4. Le langage

a) L'expression verbale

- le *mutisme* : absence de langage, intentionnelle ou non
- la *bradyphémie* : lenteur du rythme verbal
- la *logorrhée* : flot incoercible de paroles
- l'*écholalie* : répétition immédiate et fidèle des derniers mots de l'interlocuteur
- le *psittacisme* : répétition mécanique des paroles d'autrui (perroquet)
- le *bégaiement* : difficulté d'expression portant sur le débit de la parole
- le *barrage* : brusque suspension du fil du discours
- les *impulsions verbales* : parasitage du discours, souvent par des jurons
- le *maniérisme* : mode d'expression emphatique
- la *schizophasie* : langage hermétique

b) La sémantique et la syntaxe

- le *néologisme* : création d'un mot nouveau n'ayant de sens que pour le sujet
- la *glossolalie* : création d'un nouveau langage
- Les *paralogismes (délirants)* : détournement du sens des mots ; énoncés faux d'apparence logique
- l'*agrammatisme* : expression télégraphique ou monosyllabique

c) La dyslexie

Difficulté d'apprentissage de la lecture

d) Les aphasies

Troubles du langage dus à des lésions cérébrales

2.5. La mémoire

a) Les amnésies

- l'amnésie *antérograde (d'évocation)* : incapacité de fixer de nouveaux souvenirs
- l'amnésie *rétrograde (de fixation)* : incapacité d'évoquer des souvenirs antérieurs au début de la maladie
- les *amnésies psychogènes/"affectives"* : amnésies électives, périodiques et post-traumatiques

b) Les libérations mnésiques

- l'*hypermnésie* : flux de remémoration permanent ou paroxystique

c) Les paramnésies (illusions de mémoire)

- les illusions mnésique ("*ecmnésie*")
- le sentiment de "*déjà vu*", les fausses reconnaissances
- le *flashback* : souvenir intrusif d'un événement traumatique

2.6. L'intelligence

- l'*arriération* : limitation ou retard du développement intellectuel
- la *détérioration* : baisse de l'efficacité intellectuelle (avec l'âge ou la maladie)

2.7. La conscience

a) La vigilance

Troubles quantitatifs de la vigilance :

- l'*hypervigilance* : très haut niveau de vigilance
- l'*hypovigilance* : très faible niveau de vigilance

- l'*obnubilation* : lenteur de la pensée et difficulté de compréhension
- l'*hébétude* : désintégration plus profonde
- le *coma* : perte complète de conscience
- la *désorientation temporo-spatiale* : perte des repères dans le temps et l'espace

Troubles qualitatifs de la vigilance :

- le *rétrécissement de la conscience* : diminution du champ de conscience
- les *états oniroïdes* (ou *crépusculaires*) : monde proche du rêve qui envahit la conscience
- l'*onirisme* : états de rêve pathologique
- la *déréalisation* : perte du caractère familier de l'environnement

b) L'attention

- l'*hyperprosexie* : augmentation de l'attention
- l'*hypoprosexie* ou *aprosexie* : diminution de l'attention
- l'*aprosexie* : perte de la capacité attentionnelle

2.8. L'activité (psychomotrice)

a) Les déficits

- le *ralentissement psychomoteur* : lenteur, fatigue, asthénie
- la *catatonie* : négativisme, passivité
- la *catalepsie* : immobilité, "prise en masse" du sujet
- la *stupeur* : état de sidération
- certaines *paralysies hystériques* (sans causes neurologiques) :
 - *astasié* : impossibilité de se tenir debout
 - *abasié* : impossibilité de marcher
 - *aboulie* : absence ou diminution de la volonté

b) L'agitation

Formes / expressions motrices de l'excitation psychique :

- l'agitation *agressive*
- l'agitation *onirique*
- l'agitation *anxieuse*
- l'agitation *euphorique*
- l'agitation *discordante*
- l'agitation *théâtrale*

c) Les impulsions

- l'*impulsivité* : besoin impérieux d'accomplir soudainement un geste (brutal, dangereux, incongru...)
- le *raptus* : passage à l'acte clastique
- les *parakinésies* : mouvements anormaux parasites
- les *stéréotypies* : grattage, balancements, rotations, etc.
- les *dyskinésies* : hyperextensions
- les *hyperkinésies* : instabilité impulsive
- les *tics* : mouvements involontaires de groupes de muscles en liaison fonctionnelle

d) Les apraxies

Les *apraxies* : impossibilité d'exécuter volontairement des mouvements orientés vers un but

2.9. Les conduites

a) La présentation

- les *inadaptations remarquables* (à l'âge, aux normes sociales...)
- le *maniérisme* : conduite affectée, désuète
- l'*incurie* : négligence extrême de soi
- la *clinophilie* : alitement permanent

b) Les mimiques

- les *hypermimies* : exagération des mimiques
- les *hypomimies* : réduction de l'expressivité du visage

c) Le sommeil

- les *insomnies* : manque ou mauvaise qualité du sommeil
- la *somnolence* (assoupissement diurne) et l'*hypersomnie* (besoin excessif de dormir)
- le *somnambulisme* : conduite motrice pendant le sommeil

d) L'alimentation

- les *restrictions alimentaires* : limitations volontaires
- la *dysphagie* : difficulté à déglutir ou à avaler
- l'*anorexie* : diminution ou perte d'appétit
- la *boulimie* : sensation de faim intense et ingestion rapide d'une grande quantité de nourriture
- l'*hyperphagie* : prise d'aliments en quantités importantes
- la *potomanie* : ingestion de grandes quantités de liquide

- la *dipsomanie* : impulsion périodique à boire des boissons alcoolisées

e) Les sphincters

- l'*énurésie* : émission involontaire d'urine
- l'*encoprésie* : incontinence fécale

f) La sexualité

- l'*impuissance* : dysfonction érectile
- l'*éjaculation* précoce, ou absente : délai très court entre pénétration et jouissance
- la *frigidité* : absence de plaisir
- la *dyspareunie* : douleurs lors des rapports sexuels
- le *vaginisme* : empêchement de toute pénétration
- l'*addiction sexuelle* : appétit sexuel insatiable et compulsif

g) Les rituels

- domaines : alimentation, sexualité, santé...

h) Les transgressions

- les *fugues* : fuite, souvent avec prise de risque
- la *kleptomanie* : vol pathologique
- les *perversions* sexuelles (fétichisme, masochisme, voyeurisme, exhibitionnisme, sadisme, zoophilie, ondinisme)
- le *suicide*, *tentative* ou *équivalents* : intention consciente ou inconsciente de mourir
- l'*homicide* : action de tuer, volontairement ou non, un autre être humain

3. Catégories et structures

3.1. Les classifications sémiologiques

3.1.1. Les catégorisations

La classification est un mode de pensée, sous-tendu par un raisonnement

Les classifications "a-théoriques" (DSM) reposent *de facto* sur des théories de la maladie mentale

3.1.2. Les syndromes

Le syndrome se constitue à partir d'une combinaison de signes

Un syndrome est un regroupement spécifique de signes, qui peuvent avoir plusieurs étiologies et se trouver dans plusieurs pathologies. Par exemple :

- syndrome de Cotard [humeur dépressive, négation d'organes] : mélancolie, schizophrénie, hypocondrie
- syndrome de Korsakoff [amnésie antérograde sévère, troubles de la marche et de l'équilibre, fabulations, fausses reconnaissances] : alcoolisme, carence vitaminique, traumatisme

3.1.3. Les tableaux cliniques

Un tableau clinique correspond à l'ensemble des signes présentés par un patient, et constituant généralement une variante clinique d'une entité pathologique

3.2. Les entités psychopathologiques

3.2.1. Nosographie et nosologie

Nosographie : description des maladies

Nosologie : doctrine de la maladie (logique, classification, étiologie)

Formes cliniques : tableaux sémiologiques distincts relevant d'une même entité

Une entité ou maladie correspond à une abstraction (schématisation d'une situation complexe)

Les entités psychopathologiques ont des définitions instables

La notion de "maladie mentale" : une médicalisation de la souffrance psychique

3.2.2. Les entités psychiatriques et psychopathologiques

3.2.2.1. Les regroupements traditionnels

Les entités psychiatriques sont traditionnellement regroupées dans les ensembles suivants :

- 1 - les névroses (psychonévroses de défense et névroses actuelles)

- 2 - les psychoses
- 3 - les états dépressifs (non psychotiques)
- 4 - les démences
- 5 - les arriérations
- 6 - les troubles du comportement et du caractère
- 7 - les troubles mentaux liés à une affection organique
- 8 - les pathologies psychosomatiques

Les problèmes liés aux regroupements des entités : la pluralité de critères (forme, étiologie, évolution...)

3.2.2.2. Déplacement nosographique et analyse transnosographique

Les classifications sont instables, du fait d'un certain polymorphisme des symptômes

Les déplacements nosographiques désignent les zones de recouvrements sémiologiques

Exemple de déplacement nosographique entre paranoïa, névrose obsessionnelle et hypochondrie

L'analyse transnosographique consiste en une étude comparée entre les différentes affections psychiques

Les structures sont différentes, mais il existe des processus communs et donc des symptomatologies partiellement partagées. L'analyse sémiologique est donc :

- nécessaire pour étayer une analyse clinique précise de la réalité psychique singulière du patient
- mais insuffisante pour accéder pleinement à la compréhension des phénomènes psychopathologiques

La *psychopathologie clinique* va donc établir les relations à chaque fois particulières entre :

- la sémiologie
- les entités psychopathologiques
- et les processus mentaux

3.2.3. Les classifications psychanalytiques

Une composition spécifique de critères structuraux et processuels :

- la structure
- le type de relation d'objet
- le mécanisme de défense primaire
- l'étiologie

La classification de J. Bergeret est composée à partir de quatre critères :

- la symptomatologie
- le type d'angoisse
- la relation d'objet

- les mécanismes de défenses

Tableau des structures psychopathologiques, d'après Jean Bergeret, et al., *Psychologie pathologique*, Masson, 1982 :

	<i>Symptômes/signes</i>	<i>Type d'angoisse</i>	<i>Relation d'objet</i>	<i>Défenses</i>
<i>Psychoses</i>	Dépersonnalisation Délire	Morcellement	Fusionnelle	Déni Clivage du moi
<i>Etat-limite</i>	Dépression	Perte d'objet Abandon	Anaclitique	Régression
<i>Névroses</i>	Obsessionnels, hystériques, phobiques...	Castration	Génitale	Refoulement Déplacement

3.3. Structure, personnalités et pathologies

3.3.1. La notion de structure

La définition d'entités psychopathologiques comme "l'ordre du désordre" :

« Les divers syndromes mentaux se répètent dans leurs grandes lignes, d'individu à individu, avec une régularité surprenante à première vue, comme s'ils étaient soumis à une loi, de sorte que les aliénés se laissent grouper plus facilement à première vue que les êtres normaux. Le nombre de syndromes est limité, les dégradations de structure semblent suivre des tracés préformés, toujours les mêmes. Il y a de l'ordre dans le désordre. » (E. Minkowski, *Traité de psychopathologie*, 1966)

Origine de la notion de structure dans l'étude du langage

Un ensemble de "places" relatives les unes aux autres

Définition de la structure () :

- 1 - il existe un *ordre symbolique* irréductible et antérieur à l'ordre du réel et de l'imaginaire
- 2 - les places désignées dans l'espace structural sont *premières* par rapports aux éléments
- 3 - les places occupées déterminent des *effets subjectifs*
- 4 - la structure est inconsciente

3.3.1.1. La structure psychique

L'organisation inconsciente du sujet

Le passage du niveau des manifestations (clinique) à celui des organisations (structure)

La métaphore du cristal, les "lignes de fragilité"

Une structure stabilisée est dite "*compensée*"

La *décompensation* s'effectue selon l'organisation (structurale) de la personnalité

Une cohérence essentielle existe entre situation normale et situation pathologique : la structure reste la même (qu'elle soit compensée ou décompensée)

3.3.1.2. Les processus mentaux

Les processus mentaux désignent des activités psychologiques/psychiques

Ils sont inobservables directement

La perspective pathogénique (comment) complète la perspective étiologique (pourquoi)

Processus et théorie du psychisme

3.3.2. Structure et personnalité pathologique

Personnalité : organisation dynamique des aspects intellectuels, affectifs et physiologiques de l'individu. Elle est une manifestation et expression de la structure psychique

Personnalité pathologique / organisation pathologique de la personnalité : une déviation permanente d'un type de personnalité

Exemples de personnalités pathologiques et leurs évolutions (fréquentes mais *non systématiques*) :

- Personnalité obsessionnelle -> névrose obsessionnelle
- Personnalité hystérique -> névrose hystérique
- Personnalité schizoïde ou schizotypique -> schizophrénie
- Personnalité anxio-phobique -> névrose d'angoisse et phobique
- Personnalité limite -> état dépressif majeur
- Personnalité paranoïaque ou sensitive -> délires chroniques

Deux conceptions différentes des rapports entre "personnalité" et "entité pathologique"

Bibliographie

- Bergeret Jean, *La personnalité normale et pathologique, Les structures mentales, le caractère, les symptômes*, Paris, Dunod, 3e édition, 2021.
- Bergeret Jean, et al., *Psychologie pathologique* [1972], Paris, Masson, 2012.
- Bouhsira Jacques, Danon-Boileau Laurent, Janin Claude (dir.), *Nosographie psychanalytique*, Paris, PUF, 2011.
- Godfryd Michel, *Les maladies mentales de l'adulte*, Paris, PUF, 2014.
- Godfryd Michel, *Vocabulaire psychologique et psychiatrique*, Paris, PUF, 2015.
- Ionescu Serban., Jacquet Marie-Madeleine, Lhote Claude, *Les mécanismes de défense. Théorie et clinique*, Paris, Dunod, 2020.
- Lanteri-Laura Georges, « Un point de vue phénoménologique sur la sémiologie psychiatrique », *Psychothérapie phénoménologique*, MJW Éditions, 2006, p. 13-34.
- Lempérière Thérèse, Féline A., *Psychiatrie de l'adulte*, Paris, Masson, 1985.
- Minkowski Eugène, *Traité de psychopathologie*, Paris, PUF, 1966, rééd. Le Plessis-Robinson (Hauts-de-Seine), Institut Synthélabo, 1999.
- Palacio Espasa Francisco, Dufour Roland, *Diagnostic structurel chez l'enfant*, Paris, Masson, 1995.
- Pirlot Gérard, *Classifications et nosologies des troubles psychiques : approches psychiatrique et psychanalytique*, Paris, Armand Colin, 2013.
- Rabeyron Thomas, *Psychologie clinique et psychopathologie*, Paris, Armand Colin, 2018, 352 p.
- Roussillon René (dir.), *Manuel de psychologie et psychopathologie clinique générale*, Paris, Masson, 2007, 3ème édition 2018.
- Widlöcher Daniel, (dir.), *Traité de psychopathologie clinique*, Paris, P. U. F., 1994.

Annexes

A. Lexique abrégé (Samuel-Lajeunesse, Guelfi)

Bertrand Samuel-Lajeunesse, Julien Guelfi, « Lexique abrégé des termes psychiatriques », *Psychopathologie. Etudes de cas*, Paris, Puf, 1985, p. 367-384.

p. 367

ABOULIE : Sentiment général d'impuissance et d'indécision qui rend toute action impossible.

ABSENCE : Trouble paroxystique de la conscience avec amnésie, d'origine épileptique.

AFFECT : Etat psychique immédiat caractérisant le sens d'une réaction de l'organisme à un stimulus. Piéron en a décrit trois types :

- l'affect agréable, avec réaction d'expansion et de recherche
- l'affect désagréable, avec réaction de retrait et de fuite ;
- l'affect d'intérêt avec réaction d'attention et d'exploration.

Dans la théorie psychanalytique, l'affect est, comme la représentation, l'expression de la pulsion.

AGNOSIE : Trouble de la reconnaissance des éléments du monde extérieur en l'absence de toute perturbation sensorielle. On distingue plusieurs variétés de ces déficits intellectuels spécialisés ou asymbolies : agnosie visuelle, auditive, tactile, spatiale.

AGORAPHOBIE : Variété de phobie (voir ce mot) qui consiste en la peur des espaces découverts. La peur de traverser une rue ou une place et la peur de sortir se rattachent à l'agoraphobie.

AKINÉSIE : Absence de mouvement. Le sujet akinétique — ou acinésique — est figé et immobile (en l'absence de toute atteinte motrice de nature paralytique).

AMBIVALENCE AFFECTIVE : Existence simultanée de contenus affectifs opposés concernant le même objet.

AMNÉSIE : Perturbation de la mémoire qui, normalement, permet la conduite d'un récit, la connaissance et la reconnaissance du passé comme tel, et l'évocation des souvenirs. On oppose l'amnésie de mémoration ou impossibilité de fixer de nouveaux souvenirs, et l'amnésie de remémoration ou perte des souvenirs.

AMNÉSIE ÉLECTIVE : Variété d'amnésie de remémoration se rapportant à un thème déterminé. Ce trouble localisé est habituellement lié à des facteurs affectifs.

AMNÉSIE PROGRESSIVE : Variété d'amnésie de remémoration d'évolution progressive. Le passé de plus en plus lointain ne peut être évoqué par le sujet (amnésie rétrograde). Ce type d'amnésie se rencontre dans les états déficitaires, de la sénilité notamment.

p. 368-369

ANAMNÈSE : Ensemble des informations fournies par un sujet ou son entourage concernant son passé et l'histoire des symptômes survenus avant la période d'observation médicale.

ANGOISSE : Etat affectif douloureux qui consiste en l'attente poignante d'un danger imminent et imprécis. C'est une peur sans objet. La forme la plus pure est l'angoisse dite flottante, qui peut être permanente ou survenir par crises paroxystiques.

ANOREXIE : Diminution ou perte de l'appétit. Ce symptôme est d'une extrême fréquence. Il domine parfois la symptomatologie, comme dans l'anorexie mentale » (où l'anorexie vraie est moins fréquente que la restriction alimentaire).

APHASIE : Trouble du langage. Perte de la mémoire de certains des signes grâce auxquels l'homme transmet à autrui ses contenus idéiques. On distingue schématiquement les aphasies caractérisées surtout par une perte d'expression motrice du langage et celles qui témoignent principalement de troubles sensoriels ou de perturbations de la compréhension du langage.

APRAGMATISME : Absence d'activité due à une perte du désir d'agir. Ce comportement s'observe dans des circonstances psychopathologiques variables. La réduction progressive de toute activité est une des manifestations les plus précoces de l'hébéphrénie (voir ce mot).

APRAXIE : Impossibilité de conformer un mouvement à un but déterminé, en l'absence de perturbations de la coordination des mouvements volontaires (ataxie) ou de la motricité (paralysie ou parésie, mouvements anormaux).

ASTASIE – ABASIE : Impossibilité de rester immobile, de garder la position debout (astasie), et de marcher (abasie), en l'absence de troubles de la coordination, de la motricité et de la sensibilité.

ATAXIE : Trouble moteur qui consiste en un manque de coordination du mouvement, développé en l'absence de toute atteinte de nature paralytique.

ATHYMIE ou ATHYMHORMIE : Perturbation de l'humeur qui consiste en une perte du tonus affectif de base. L'athymie est opposée aux exaltations de l'humeur ou hyperthymies.

ATTITUDES CONTRAPHOBQUES : Stratagèmes utilisés pour échapper à l'angoisse phobique ou pour mieux la surmonter. On distingue les conduites d'évitement (fuite simple ou hyperactivité ayant le sens d'une « fuite en avant ») et les conduites de rassurement qui consistent à affronter la situation redoutée en compagnie d'un personnage ou d'un objet vécus comme sécurisants (objet contraphobique).

AUTISME : Mode de pensée désinséré de la réalité du monde extérieur, dans lequel il existe une nette prédominance de la vie intérieure et des tendances à l'abstraction.

AUTOMATISME MENTAL : Syndrome décrit par G. de Clérambault qui comprend, diversement associées, plusieurs variétés d'hallucinations psychiques. Le sujet peut éprouver le sentiment qu'il a perdu son autonomie de pensée. Il a des pensées qui lui sont étrangères. Il ébauche contre sa volonté des paroles qui lui sont imposées (hallucinations verbomotrices du syndrome d'influence). Il se sent en effet influencé et dépossédé de sa propre volonté. Plus encore, il peut penser que son langage intérieur est diffusé, que ses idées et actes sont commentés (commentaire des actes) ou répétés (écho de la pensée). Le syndrome d'automatisme mental se rencontre au cours de diverses psychoses, aiguës ou chroniques, notamment au cours des schizophrénies.

BARRAGE : Interruption brusque, en apparence immotivée, d'un acte ou du langage. Ce trouble, lié à une rupture du cours de la pensée, est caractéristique des psychoses schizophréniques.

BOUFFÉE DÉLIRANTE : Voir Psychose délirante aiguë.

BOULIMIE : Perturbation par excès des conduites alimentaires ; besoin excessif de manger, le plus souvent lié à une sensation accrue, voire continue, de faim. La boulimie revêt parfois un aspect impulsif en dehors même d'une faim excessive.

BRADYPSYCHIE : Ralentissement du cours de la pensée.

CATALEPSIE : Perte de l'initiative motrice avec conservation des attitudes.

CATAPLEXIE : Perte soudaine, plus ou moins complète, du tonus musculaire.

CATATONIE : Etat caractérisé par le négativisme, l'immobilité avec rigidité musculaire, la conservation des attitudes imposées et parfois des épisodes d'agitation.

CLAUSTROPHOBIE : Variété de phobie (voir ce mot) consistant en une peur des lieux clos.

CLINOPHILIE : La clinophilie ou clinomanie désigne la tendance à rester couché en permanence.

COARCTÉ : Qualificatif utilisé par Rorschach pour désigner un type psychologique particulier, distinct de l'extratensif et de l'introversif (voir ces mots). Les sujets coarctés (ou coartés) sont a rétractés ». Leur énergie instinctuelle, faible, ne leur permet une orientation psychologique ni vers les objets du monde extérieur, ni vers leur vie intérieure.

CÆNESTOPATHIE : Perturbation de la cœnesthésie ou sensibilité, interne (sensibilités proprioceptive et intéroceptive qui fournissent une appréciation globale des sensations corporelles). La cœnestopathie consiste en des sensations corporelles anormales, gênantes, pénibles, vaguement douloureuses parfois ; elle survient dans un contexte anxieux, dépressif ou délirant (voir Hypochondrie).

COMITIALITÉ : Voir Epilepsie.

p. 370-371

COMPULSION : Contrainte qui s'impose à l'esprit malgré tous les efforts déployés pour la chasser. S'il s'agit d'une idée, on parle plutôt de représentation obsédante ou d'obsession (voir ce mot). On réserve habituellement le terme de compulsion aux cas où la contrainte concerne une conduite ou une action (action compulsive ou compulsion à...) jugée par le sujet ridicule, pathologique, absurde, mais qu'il ne peut éviter malgré sa « lutte anxieuse »).

CONFUSION MENTALE : Etat pathologique de la conscience qui associe à l'obnubilation (obtusion intellectuelle) une désorientation dans le temps et dans l'espace. Dans l'état confuse-onirique, la confusion mentale s'accompagne d'un onirisme, état psychique voisin du rêve.

CONVERSION SOMATIQUE : Manifestation somatique en règle réversible, sans base organique, touchant le système de relation (motricité, sensibilité, fonctions sensorielles). Ce trouble, lié à des facteurs émotionnels, est considéré comme une conversion de l'angoisse en manifestations physiques. L'hystérie de conversion est une névrose dans laquelle le symptôme (à déterminisme symbolique) vise à supprimer l'angoisse (cf. la « belle indifférence » classique de la conversion « réussie »).

COPROLALIE : Tendance à répéter des paroles grossières.

COTARD (Syndrome de) : Délire de négation d'organes (parfois associé à des thèmes d'immortalité et de damnation éternelle).

CYCLOTHYMIE : Humeur mobile, vibrant à l'unisson avec les moindres modifications de l'ambiance (syntonie). Les sujets cyclothymiques sont sociables et réalistes.

DÉLIRE : L'idée délirante, distincte de l'erreur de jugement ou de l'idée fausse, est une conviction, plus ou moins absolue, inaccessible à la critique, au raisonnement et à la démonstration. Elle est une « évidence interne », expression d'une perturbation grave de « l'intégration du moi » dans le monde. Le mécanisme à partir duquel s'élabore le délire peut être hallucinatoire, interprétatif, imaginatif ou intuitif.

Les thèmes délirants les plus fréquents sont des idées de persécution, de grandeur, de filiation, de possession, de religiosité mystique.

La structure du délire permet d'opposer les délires cohérents, bien systématisés, relativement crédibles (dont le type est le délire paranoïaque), aux délires incohérents, mal systématisés, avec des thèmes flous et changeants (dont le type est le délire paranoïde de la schizophrénie).

DÉLIRE ALCOOLIQUE SUBAIGU : Etat confusionnel et délirant d'origine alcoolique. Le tableau se développe en quelques jours avec une agitation anxieuse et une insomnie. Le délire, d'aspect oniroïde, est riche en hallucinations. Les thèmes délirants sont variables ; les idées de jalousie et de persécution sont les plus fréquentes. La forme aiguë du délire alcoolique est le *delirium tremens* ; elle s'accompagne d'une altération de l'état général.

DÉLIRE D'IMAGINATION : Variété de psychose délirante chronique non dissociative. Les thèmes délirants s'y élaborent à partir de mécanismes imaginatifs et intuitifs.

DÉLIRE DE JALOUSIE : Délire paranoïaque. Voir Paranoïa.

DÉLIRE ONIROÏDE : Etat délirant qui coexiste avec une désintégration de la conscience de type confusionnel. Le terme oniroïde marque les rapports de cet état pathologique de la conscience avec la pensée du rêve et son imagerie visuelle (voir Onirisme).

DÉLIRE DE PERSÉCUTION : Voir Délire, Paranoïa, Schizophrénie paranoïde.

DÉMENCE : Déficit global, progressif et acquis, de l'intelligence. On distingue les démences séniles, préséniles (maladies d'Alzheimer et de Pick), les démences d'origine vasculaire (démence artériopathique), infectieuse (paralysie générale, d'étiologie syphilitique), toxique (démence alcoolique) et traumatique (démence post-traumatique).

DÉPERSONNALISATION : Trouble de la conscience au cours duquel le sujet éprouve l'impression d'une transformation de sa personnalité — qu'il ne reconnaît plus — et d'une modification corporelle. Cette impression de modification de soi-même et du monde extérieur est souvent qualifiée de « sentiment d'étrangeté ». Le syndrome de dépersonnalisation s'accompagne parfois d'un sentiment de déréalisation (le monde environnant devient indistinct, flou, lointain, « déréel »). La dépersonnalisation s'observe dans des circonstances psycho-pathologiques variées : angoisse lors d'états névrotiques divers, dépression profonde de type mélancolique, dédoublement hallucinatoire de la personnalité au cours de certaines psychoses chroniques.

DÉPRESSION ATYPIQUE : Etat dépressif au sein duquel la bizarrerie des contenus idéiques, le flou de la pensée, la froideur et le retrait affectif, la discordance enfin évoquent une forme dysthymique de schizophrénie.

DÉPRESSION D'INVOLUTION : Forme clinique de dépression. Ces accès dépressifs surviennent pour la première fois tardivement, entre cinquante et soixante ans, surtout chez la femme. La symptomatologie associée au syndrome dépressif une agitation anxieuse et, souvent, des thèmes délirants variés (persécutifs et hypocondriaques).

DÉPRESSION NÉVROTIQUE : Etat névrotique caractérisé par une symptomatologie dépressive réactionnelle (voir Réaction pathologique) à un conflit interne ou à un événement identifiable comme la perte d'une personne aimée ou d'un bien précieux.

DÉPRESSIVE (Humeur) : Perturbation de l'humeur ou thymie qui revêt une tonalité douloureuse. L'humeur dépressive est faite d'une vision pessimiste du monde et de soi-même. Le sujet insatisfait, dévalorisé et déprécié, éprouve au maximum une « douleur morale » qui s'exprime par des convictions erronées et pessimistes (mélancolie). La dépression entraîne un désintérêt global, péniblement ressenti. Dans certaines formes, des signes somatiques, tel un ralentissement psychomoteur, peuvent être au premier plan ; ailleurs, l'angoisse associée à la dépression peut, au contraire, être responsable d'une agitation incoercible. Voir Etats dépressifs.

DÉRÉALISATION : Trouble de la conscience, généralement associé à la dépersonnalisation, au cours duquel le monde environnant paraît étrange, lointain et bizarre.

p. 372 - 373

DÉSÉQUILIBRE PSYCHIQUE : Voir Personnalité pathologique et Personnalité psychopathique.

DÉSORIENTATION : Perte des repères spatiaux, temporels (désorientation temporo-spatiale), intellectuels et affectifs habituels.

DÉTÉRIORATION MENTALE : Affaiblissement de l'efficacité intellectuelle. Le concept de détérioration mentale est un concept opérationnel qui ne préjuge pas de la cause du déficit et de sa non-réversibilité éventuelle. Le fonctionnement intellectuel peut notamment être entravé par des facteurs affectifs, émotionnels (déficits fonctionnels des inhibitions anxieuses ou dépressives par exemple).

DÉVIATIONS SEXUELLES : La déviation concerne souvent le choix de l'objet sexuel : homosexualité, pédophilie, gérontophilie, voire nécrophilie. L'homosexualité, active, passive ou mixte, peut s'associer au travestisme (port de costume du sexe opposé) ou au transsexualisme (désir de changement de sexe par identification au sexe opposé). La déviation sexuelle peut concerner l'acte sexuel proprement dit. Elle est alors liée aux modalités d'obtention de la satisfaction : voyeurisme ou scopophilie, exhibitionnisme, fétichisme, sadisme ou masochisme. Les diverses déviations sexuelles n'ont guère de spécificité nosographique. Elles se rencontrent chez les personnalités pathologiques et au cours des névroses, des psychoses, ou des atteintes organiques (démences).

DIPSOMANIE : Impulsion périodique à boire, généralement des boissons alcoolisées.

DISCORDANCE IDÉO-AFFECTIVE : Trouble du comportement qui consiste en une discordance entre l'expression des émotions et les contenus verbaux. La discordance se traduit par un maniérisme, des mimiques inadaptées (parasitisme mimique) ou des rires immotivés. C'est un symptôme fondamental des schizophrénies.

DISSOCIATION : Etat pathologique au cours duquel la personnalité ne fonctionne plus comme un tout intégré, mais comme un assemblage d'éléments mal connectés dont chacun a une activité relativement indépendante. Cette fragmentation de la personnalité isole la sphère intellectuelle et la sphère affective (dissociation idéo-affective). A l'intérieur même de la sphère intellectuelle, cette fragmentation isole diverses composantes (troubles de l'association des idées, barrages). La dissociation se rencontre, dans sa forme typique, au cours des schizophrénies.

DYSPHORIE : Trouble de l'humeur qui consiste en une impression de malaise, de désenchantement et d'insatisfaction générale avec instabilité thymique.

ECHOLALIE : Répétition automatique, « en écho » et stéréotypée, de mots ou de phrases prononcés par autrui.

ÉCLAMPSIE : Convulsions dues à une auto-intoxication dont le signe biologique majeur est l'élévation du taux sanguin de l'urée. L'éclampsie s'observe surtout au cours des trois derniers mois de la grossesse.

ECMNÉSIE : Perturbation de la mémoire au cours de laquelle le passé est revécu comme présent.

ENCÉPHALOPATHIES ALCOOLIQUES : Atteintes cérébrales liées à l'alcoolisme (par avitaminose du groupe B). Elles comprennent le syndrome de Korsakov (voir ce mot) où il existe une atteinte bilatérale des tubercules mamillaires et l'encéphalopathie de Gayet-Wernicke avec obnubilation, ophtalmoplégie et myoclonies.

ENURÉSIE Incontinence vésicale.

EPILEPSIES Accidents neuro-psychiques paroxystiques d'origine encéphalique résultant de la décharge hypersynchrone d'un groupe de neurones ; ils se traduisent principalement, soit par des crises convulsives généralisées, soit par des crises convulsives localisées à une partie du corps.

EPILEPSIE TEMPORALE : Forme clinique d'épilepsie, caractérisée par des troubles mentaux « critiques », à début et à fin brusques, de durée le plus souvent brève. S'y observent des crises d'agitation agressive, des automatismes psychomoteurs (fugues, actes médico-légaux) avec amnésie, des hallucinations avec ou sans perturbation de la vigilance (« absence temporaire » ou dreamy state de la crise uncinée. Voir ces mots).

EREUTHOPHOBIE : Variété de phobie qui consiste en la peur panique de rougir en public. On distingue l'éreuthophobie de l'érythrophobie qui est la phobie de la couleur rouge.

EROTOMANIE : Illusion délirante d'être aimé (voir Paranoïa).

ETAT CRÉPUSCULAIRE : Trouble de la conscience voisin de la rêverie. Obnubilation transitoire avec conservation d'une activité en apparence ordonnée.

ETATS DÉPRESSIFS : Etats caractérisés par :

- 1) un syndrome psychique : modification pénible de l'humeur, tristesse pathologique, ralentissement des processus intellectuels et des pulsions instinctuelles (inhibition psychique) et ralentissement de l'activité physique (inhibition motrice) ; une anxiété et des idées délirantes peuvent s'y associer ;
- 2) un syndrome physique (inconstant) : insomnie, troubles de l'appétit (anorexie ou boulimie), sécheresse de la bouche, constipation, amaigrissement. Voir Dépressive (Humeur).

ETAT MIXTE : Tableau clinique complexe associant divers symptômes de l'excitation maniaque à des éléments de la série dépressive. Cet aspect clinique de la psychose maniaco-dépressive a une symptomatologie fluctuante, souvent variable d'un instant à l'autre.

EXCITATION ATYPIQUE : Etat d'excitation et d'euphorie d'allure maniaque au sein duquel la bizarrerie des contenus idéiques, le flou de la pensée, la froideur et le retrait affectifs, l'asyntonie, la discordance enfin évoquent une forme dysthymique de schizophrénie.

EXTRATENSIF : Qualificatif utilisé par Rorschach pour désigner un type pathologique particulier. Les sujets extratensifs (qui correspondent aux extravertis — voir extraversion) sont sensibles aux diverses sollicitations de leur environnement ; ils s'extériorisent aisément, réagissent vivement aux stimulations de l'ambiance (sans pouvoir organiser leurs conduites de façon volontaire). Le type psychologique inverse est qualifié par Rorschach d'introversif — voir Introversion (Introverti). La typologie de Rorschach distingue un troisième type : le type coarcté (voir ce mot).

EXTRAVERSION : Trait de personnalité fondé sur l'attitude du sujet envers le monde. L'extraversion désigne une mobilité psychique parfaitement adaptée aux excitations du monde ambiant. Les sujets extravertis oscillent facilement entre la gaieté et la tristesse ; on leur oppose les sujets introvertis (voir Introversion).

FABULATION : Perturbation qui consiste à prendre pour des souvenirs des productions imaginaires plus ou moins riches. Ce symptôme, inconscient, est relativement fréquent au cours des amnésies (voir ce mot). Dans la confabulation, les patients fabulent « par suppléance » sur une période passée pour laquelle ils ont une amnésie lacunaire. La fabulation, véritable délire de mémoire, doit être distinguée de la mythomanie (voir ce mot).

FUITE DES IDÉES : Défilé idéique accéléré. Les idées se succèdent et s'enchaînent, sans que le sujet puisse fixer son attention sur l'une d'elles. La fuite des idées est un symptôme d'excitation psychique.

GANSER (Syndrome de) : Méconnaissance systématique de la réalité ambiante. A des questions simples le patient répond « à côté » ou de façon absurde. Ce syndrome est le plus souvent rattaché à la pathologie névrotique de type hystérique.

GÂTISME : Incontinence des urines et des matières fécales.

HALLUCINATION : Perception sans objet à laquelle le sujet adhère pleinement. Les hallucinations psychosensorielles peuvent être auditives, visuelles, plus rarement olfactives, gustatives, tactiles ou cœmethésiques. Les hallucinations oniroïdes, surtout visuelles, se développent dans un contexte de conscience perturbée. Elles ressemblent aux images du rêve. Les hallucinations psychiques font partie du syndrome d'automatisme mental (voir ce mot).

HALLUCINOSE Perception sans objet, reconnue par le sujet comme un phénomène pathologique et « irréel ».

HÉBÉPHRÉNIE Forme clinique de schizophrénie (voir ce mot).

HÉBOÏDOPHRÉNIE : Forme clinique de schizophrénie, caractérisée par la coexistence, chez l'adolescent, de symptômes de type hébéphrénique et de conduites antisociales agressives.

HÉMATOME SOUS-DURAL : Collection sanguine, diffuse ou circonscrite, le plus souvent d'origine traumatique, siégeant entre la dure-mère et le cortex cérébral.

HÉMIANOPSIE : Diminution Ou perte de la vue dans une moitié du champ visuel. Ce trouble est le plus souvent binoculaire. Une hémianopsie est dite homonyme, lorsqu'elle concerne les mêmes moitiés (droite ou gauche) de chaque champ visuel, hétéronyme, lorsqu'elle est bitemporale ou binasale.

HÉMIPLÉGIE : Atteinte plus ou moins complète de la motricité de la moitié du corps. L'hémiplégie est due à une lésion unilatérale des voies motrices principales au niveau

des neurones moteurs centraux. Lorsque l'atteinte motrice est incomplète ou partielle, on parle d'hémiplégie partielle ou d'hémi-parésie.

HISTRIONISME Voir Personnalité hystérique.

HYPERTHYMIE Exaltation de l'humeur. Elle peut être dépressive ou euphorique.

HYPNOSE : Etat de conscience particulier, au cours duquel la vigilance est amoindrie. Cet état, dont le déclenchement nécessite une extrême suggestibilité, est distinct du sommeil physiologique.

HYPOCONDRIE : Etat caractérisé par une exagération des sensations cénesthésiques, péniblement éprouvées. Parfois organisée en véritable système délirant (conviction absolue d'avoir une maladie organique), souvent accompagnée d'anxiété et de symptômes névrotiques divers, l'hypocondrie peut, dans certains cas, être considérée comme un équivalent dépressif.

ILLUSION : Trouble de la perception qui consiste en une simple déformation d'une perception réelle.

INTERPRÉTATION (délirante) : Variété d'erreur de jugement. Raisonnement faux qui attribue à un phénomène réel un sens particulier trouvant sa source dans l'affectivité propre du sujet.

INTROVERSION : Trait de personnalité fondé sur l'attitude du sujet envers le monde. L'introversion désigne une mobilité psychique limitée, peu adaptée aux excitations du monde ambiant. Les sujets introvertis sont repliés sur eux-mêmes. Leur mode de pensée est caractérisé par la prédominance de la vie intérieure et des tendances à l'abstraction. On leur oppose les sujets extravertis (voir Extraversion).

INTUITION : Mode de connaissance directe subjective « qui éclaire soudainement l'esprit ». L'intuition est une révélation qui surgit en l'absence de toute donnée sensorielle objective et de toute opération intellectuelle rationnelle. L'hyperémotivité, l'anxiété et l'introspection favorisent son apparition. Dans l'intuition délirante, cette activité psychologique imaginative sert d'amorce à des constructions pathologiques secondaires (déductions et interprétations a posteriori).

IVRESSE PATHOLOGIQUE : Crise excito-motrice due à un excès alcoolique, où des comportements agressifs et impulsifs apparaissent dans un contexte volontiers confuso-délirant.

p. 376 - 377

KLEPTOMANIE : Impulsion obsédante à voler. Le passage à l'acte fait céder « la lutte anxieuse » préalable. Ce symptôme, souvent invoqué, est rare.

KORSAKOV (Syndrome de) : Défini par une triade symptomatique : amnésie- de mémorisation, fabulations et désorientation, ce syndrome s'observe, entre autres, au cours de la psychose polynévritique de Korsakov, essentiellement d'étiologie éthylique.

MANIAQUE (Humeur) : Variété pathologique de l'humeur, constituée d'affects expansifs, d'euphorie morbide et, parfois, de sentiments délation (voir Psychose maniaco-dépressive).

MANIE : Etat caractérisé par :

- un syndrome psychique : exaltation de l'humeur, excitation psychique et excitation motrice, souvent associées à l'anxiété ;
- un syndrome physique : insomnie matinale, augmentation de l'appétit, amaigrissement, hyperthermie et tachycardie.

MANIÉRISME : Comportement caractérisé par des attitudes et des expressions (mimique, gestes, langage) compliquées, affectées, dépourvues de simplicité et de naturel.

MÉLANCOLIE : Variété pathologique de l'humeur, constituée d'affects dépressifs profonds, intenses et intolérables. Voir Etats dépressifs et Psychose maniaco-dépressive.

MENTISME : Rumination mentale plus ou moins incoercible. Le mentisme, manifestation anxieuse, accompagne le plus souvent les insomnies d'endormissement.

MORIA : Trouble de l'humeur caractérisé par une jovialité, une subexcitation euphorique, et une tendance aux facéties. Des éléments confusionnels peuvent s'associer à ces troubles. Ce syndrome a été décrit dans les tumeurs du lobe frontal.

MUTISME : Ralentissement ou arrêt de la production verbale. Le mutisme peut être volontaire (jeu, opposition, simulation) ou involontaire (sidération ou délire).

MYTHOMANIE : Tendance, plus ou moins inconsciente, à mentir. Variété d'imagination pathologique dans laquelle le sujet ne parvient plus à distinguer la réalité objective et les productions imaginaires.

NEUROLEPTIQUE : Groupe hétérogène de substances chimiques agissant principalement sur les formations nerveuses supérieures, caractérisées par leurs seuls effets cliniques, en particulier

- réduction des phénomènes délirants ;
- réduction de l'agitation psychomotrice
- sédation de l'anxiété.

Ces médicaments produisent souvent des effets secondaires psychomoteurs et végétatifs.

NÉVROSE : Etat d'inadaptation affective principalement caractérisé par une anxiété née de conflits le plus souvent inconscients. L'anxiété est perçue directement ou contrôlée par différents mécanismes psychologiques, source de symptômes. Les névroses sont classées en fonction de cette symptomatologie (névrose d'angoisse, hystérique, obsessionnelle, hypocondriaque). A la suite des travaux de Jaspers, les névroses ont été différenciées des psychoses, car elles sont psychologiquement « compréhensibles » et, typiquement, elles n'entraînent pas de distorsion importante du « sens du réel ».

NÉVROSE HYSTÉRIQUE : La névrose hystérique est définie par l'existence de symptômes somatiques : les conversions (voir ce mot), et de troubles psychiques, isolés ou associés :

- troubles des conduites instinctuelles (troubles du sommeil, de l'appétit, de la sexualité) ;
- troubles des fonctions intellectuelles (inhibition, troubles mnésiques, troubles partiels de la conscience : somnambulisme, fugue, états seconds, états crépusculaires) -,
- troubles de l'humeur, en particulier syndromes dépressifs. Ces symptômes ont en commun leur mobilité, leur association fréquente et leur réactivité en fonction des circonstances.

NOSOPHOBIE : Peur obsédante de la maladie (cancer, syphilis, microbes). Elle peut s'accompagner de rites de purification. Voir Obsession.

OBNUBILATION : Obscurcissement de la conscience. Voir Confusion mentale.

OBSESSION : Intrusion dans la conscience d'une pensée qui l'assiège (voir Compulsion) et dont le sujet, malgré ses efforts, ne peut se débarrasser. La pensée, jugée comme absurde, pathologique, s'impose et la « lutte anxieuse » du sujet est inefficace. Les idées obsédantes sont de nature variée, abstraites, symboliques. Elles peuvent consis-

ter en des doutes ou des scrupules perpétuels. Elles s'accompagnent volontiers de rites (voir ce mot) conjuratoires. Dans les obsessions impulsives, communément dénommées phobies d'impulsion, le sujet est obsédé par l'idée qu'il pourrait être poussé à commettre un acte dangereux, criminel ou sacrilège. Les obsessions ne sont pas spécifiques du registre névrotique. Certaines formes de schizophrénie, de mélancolie, de démence ou d'atteinte organique cérébrale ont parfois une semblable expression clinique prévalente.

OBTUSION : Trouble de la conscience. Voir : Obnubilation et Confusion mentale.

OLIGOPHRÉNIE : Déficit global et congénital de l'intelligence. Dans un ordre de gravité croissante, la terminologie française distingue, en fonction du quotient intellectuel, le niveau limite (Q.I. : 70-79), la débilité mentale (Q.I. : 50-69), l'arriération mentale moyenne (Q.I. : 30-49) et l'arriération mentale profonde (Q.I. : inférieur à 30). Ces états déficitaires peuvent être dus soit à une cause héréditaire génétique, soit à une cause exogène agissant pendant la grossesse, au moment de la naissance ou dans la première enfance.

ONIRISME : Trouble de la conscience de type confusionnel que l'on compare à un rêve — le plus souvent pénible — poursuivi à l'état de veille.

p. 378-379

PARALOGISME : Trouble du langage. Emploi de mots habituels dans un sens particulier, plus ou moins hermétique.

PARALYSIE GÉNÉRALE : Méningo-encéphalite diffuse d'origine syphilitique (période tertiaire de la maladie). Elle réalise un tableau d'affaiblissement intellectuel progressif d'évolution démentielle, s'accompagnant de manifestations délirantes (classiquement mégalomaniaques).

PARAMNÉSIES : Perturbations de la mémoire parmi lesquelles on distingue :

- les fausses reconnaissances ; le sujet identifie comme les ayant déjà vues des personnes qu'il rencontre pour la première fois (un aspect particulier en est l'illusion des sosies),
- les fabulations ; le sujet évoque des « souvenirs » de faits n'ayant pas eu lieu. Ce trouble, véritable délire de mémoire, servirait à compenser des lacunes mnésiques. Il doit être distingué de la mythomanie (souvenirs mensongers) et de « l'illusion de déjà vu ».

PARANOÏA : Psychose délirante chronique non dissociative. Le délire paranoïaque est organisé, bien systématisé. Il paraît trouver sa source dans l'interprétation pathologique de faits réels. Il se développe avec une apparente logique et non sans une certaine vraisemblance. Les thèmes les plus fréquents sont :

- la persécution ; le persécuté est volontiers dangereux, agressif et sthénique ;
- la revendication ; le sujet engage des procès pour obtenir réparation d'un préjudice, d'un dommage ;
- la passion ; dans les délires passionnels, l'activité délirante s'organise autour d'un thème central, érotomanie ou jalousie.

PARANOÏAQUES (Etats) : On distingue :

- la paranoïa ou psychose paranoïaque
- les développements paranoïaques, psychologiquement compréhensibles, en fonction de la personnalité de l'individu ;

- les réactions paranoïaques, psychologiquement compréhensibles, par rapport à un événement jouant un rôle prépondérant dans le déclenchement des symptômes ;
- la personnalité paranoïaque (voir ce mot).

PARANOÏDE (Délire) : Adjectif caractérisant l'absence de systématisation et la laxité de l'organisation de certains délires (par opposition à paranoïaque). Les délires paranoïdes s'observent essentiellement dans l'évolution de certaines schizophrénies.

PARAPHRÉNIES : Variétés de délires chroniques caractérisés par :

- l'absence de dissociation ;
- la richesse intuitive et imaginative de leurs mécanismes
- la fréquence des thèmes extraordinaires
- l'absence de systématisation ;
- la juxtaposition d'un monde délirant au monde réel auquel le malade continue longtemps à bien s'adapter.

PARASITISME MIMIQUE : Voir Discordance idéo-affective.

PERSONNALITÉ HYSTÉRIQUE : Les principaux traits de ce type de personnalité pathologique sont le théâtralisme, la mythomanie, la suggestibilité et l'inconsistance du moi. Le théâtralisme (histrionisme), souvent associé à une labilité émotionnelle, rend compte de l'exagération dans l'expression des émotions (dramatisation). De même, l'érotisation des relations interindividuelles contraste avec une sexualité conflictuelle. La suggestibilité et l'inconsistance du moi expliquent la dépendance affective qui s'exprime le plus souvent sur un mode passif (personnalité passive-dépendante). La quête affective de la personnalité hystérique, qui cherche soutien et réassurance, est marquée du sceau de l'inconsistance, de l'insatisfaction et de l'échec inéluctable.

PERSONNALITÉS PATHOLOGIQUES : Déviations quantitatives (et non qualitatives) de la personnalité normale. Dans ce cadre, la pathologie tient moins à la présence de symptômes proprement dits qu'à un certain style de vie, une manière d'être. L'organisation pathologique du caractère a fait l'objet de descriptions psychodynamiques sous le nom de « caractère névrotique ». Selon cette conception, contrairement à la névrose proprement dite, dans laquelle les pulsions s'extériorisent sous la forme déguisée de symptômes (compromis), dans le caractère névrotique, le sujet construit contre les pulsions indésirables de véritables digues (carapace caractérielle) qui visent à empêcher l'irruption pulsionnelle sous quelque forme que ce soit. Les principaux types de personnalité pathologique peuvent être décrits sous la forme d'une constellation particulière de traits de caractère (voir ci-dessous).

PERSONNALITÉ PARANOÏAQUE : Personnalité pathologique dont les traits de caractère les plus marquants sont l'hypertrophie du moi avec orgueil, la méfiance avec une méconnaissance hostile de l'entourage et des interprétations malveillantes des actes d'autrui, la fausseté du jugement enfin, avec rigidité du caractère et raisonnements paralogiques. Les personnalités paranoïaques « sensibles » sont, en outre, caractérisées par une sensibilité extrême et par une incapacité de décharge des expériences émotionnelles. Ces sujets sont volontiers culpabilisés, insécurisés, subissant douloureusement, mais en silence, ce qu'ils ressentent comme une malveillance d'autrui à leur égard.

PERSONNALITÉ PSYCHASTHÉNIQUE-OBSESSIONNELLE : Ce type de personnalité pathologique regroupe trois types pathologiques de caractère, que l'on trouve, en fait, diversement associés :

- a) La personnalité psychasthénique : elle se traduit par une tendance aux scrupules et une inhibition. Ces sujets sont voués à une introspection constante. Leurs sentiments d'incomplétude et leurs crises de conscience rendent toute action et toute décision se rapportant au réel et au concret difficiles.
- b) La personnalité obsessionnelle ou compulsive : elle est dominée par des doutes pénibles concernant toute action, avec vérifications, ruminations, hésitations.
- c) Le caractère anal ; il est défini par une triade : économie, ordre, et entêtement. Un entêtement obstiné, le goût de l'ordre méticuleux, le moralisme rigide, le souci d'économie, la tendance au collectionnisme caractérisent habituellement ces sujets.

p. 380-381

PERSONNALITÉ PSYCHOPATHIQUE : Variété de personnalité pathologique connue en France sous le nom de déséquilibre psychique et, dans la littérature anglo-saxonne, sous celui de personnalité sociopathique, en raison de la fréquence des comportements antisociaux. Les personnalités psychopathiques se caractérisent par l'instabilité affective, l'impulsivité, l'inadaptation globale (familiale, scolaire, sociale et professionnelle). La biographie des psychopathes déséquilibrés traduit toujours leur instabilité fondamentale, affective et socioprofessionnelle. Parmi les conduites sociales déviantes, on relève souvent une délinquance récidivante, incorrigible. Des perversions sexuelles et des toxicomanies, troubles non spécifiques, se rencontrent volontiers, liées au besoin d'expériences sans cesse nouvelles, et, peut-être, à une lutte contre des tendances dysphoriques (syn. : personnalité antisociale).

PERSONNALITÉ SENSITIVE : Voir Personnalité paranoïaque.

PERVERSION SEXUELLE : Déviation de la conduite sexuelle par déviation du but (objet du désir) ou des moyens utilisés pour obtenir la satisfaction sexuelle (modalités de l'acte sexuel). Voir Déviation sexuelle. Adj. : perversi. La perversion est à distinguer de la perversité (voir ci-dessous).

PERVERSITÉ : Recherche systématique de conduites antisociales, agressives, vécues sans culpabilité. Satisfaction éprouvée lors de la souffrance, sexuelle ou morale, d'autrui. Syn. : malignité -, adj. : pervers. La perversité est à distinguer de la perversion (voir ce mot).

PHOBIE : Variété d'angoisse. Crainte, reconnue par le patient comme pathologique, déclenchée par la présence d'un objet, d'une situation ou d'une personne n'ayant pas en eux-mêmes de caractère objectivement dangereux. Par opposition à l'angoisse flottante, on qualifie cette variété clinique d' « angoisse liée » ; elle disparaît en effet immédiatement lorsque le sujet évite les circonstances qui la provoquent. On parle de pantophobie, lorsque tout événement (ou des événements multiples) sont ressentis par le sujet comme dangereux et déclenchent une crise d'angoisse. La peur d'être poussé à commettre un acte dangereux, criminel ou sacrilège (phobie d'impulsion) est, en réalité, une idée obsédante (voir infra et Obsession).

PHOBIE D'IMPULSION : Idée obsédante qui consiste en la peur d'être poussé à commettre un acte agressif, dangereux, criminel, sacrilège, ridicule ou scandaleux : peur de

prononcer des insultes grossières, peur de tuer un proche avec un couteau, peur d'être envahi par des pensées à thèmes sexuels...

PICK (Maladie de) : Variété de démence (voir ce mot) présénile, due à une atrophie fronto-temporale. La détérioration mentale est d'apparition précoce et d'évolution rapide. Des troubles de l'humeur, à type d'euphorie joviale, sont fréquemment associés à la démence.

PLACEMENT : Terme utilisé pour préciser les modalités d'hospitalisation des malades mentaux. On distingue :

1. Le placement d'office : Il s'agit d'une mesure administrative, prise par arrêté préfectoral, ou, en cas d'urgence, par le maire. Un procès-verbal et un certificat médical d'internement sont indispensables pour l'exécution de cette mesure. Le malade interné ne peut sortir de l'hôpital qu'à la suite d'un nouvel arrêté préfectoral, autorisant cette sortie après avis du médecin traitant.

2. Le placement volontaire : L'internement est, dans ce cas, demandé par la famille du malade. Un certificat médical d'internement est toujours nécessaire. Dans les deux cas, les modalités de l'internement sont précisées dans la loi du 30 juin 1838. Deux certificats médicaux sont obligatoires : le « certificat de placement », à l'entrée, et le certificat « immédiat » dans les 24 heures qui suivent, établi par un autre médecin, qui confirme ou non la mesure d'internement.

3. Le placement libre : Ce mode d'hospitalisation est celui des cliniques privées et des services de psychiatrie des hôpitaux généraux ; il est de plus en plus souvent employé dans les hôpitaux psychiatriques. La réglementation de ce régime d'hospitalisation est celle qui régit les hôpitaux généraux.

POTOMANIE : Désir quasi constant de boire. La potomanie doit être distinguée de la dipsomanie ou impulsion périodique à boire des boissons alcoolisées.

PRESBYOPHRÉNIE : Variété de démence sénile qui intéresse surtout la femme âgée ; au syndrome démentiel s'associent une confusion mentale, des fabulations, des fausses reconnaissances, une jovialité et des idées délirantes.

PSYCHASTHÉNIE : Tableau clinique névrotique qui comprend une fatigabilité importante, des difficultés de concentration et une réduction d'activité (motrice, sexuelle). Sur ce fond chronique associé à des hésitations et des doutes perpétuels, surviennent des paroxysmes obsédants et des crises d'angoisse avec, parfois, un syndrome de dépersonnalisation-déréalisation.

PSYCHOSE : Désordre mental majeur, au cours duquel les possibilités de l'individu de penser, de réagir émotionnellement, de se souvenir, de communiquer, d'interpréter la réalité et d'avoir un comportement approprié sont nettement diminuées. Ce trouble est souvent caractérisé par une humeur inadéquate, une diminution du contrôle pulsionnel, et des symptômes, tels un délire et des hallucinations. Les psychoses entraînent le plus souvent un grave handicap social.

PSYCHOSE DÉLIRANTE AIGUË : Tableau clinique dont la symptomatologie est d'apparition brutale, rapidement changeante et bruyante. L'expérience hallucinatoire est habituellement riche et complexe. Les thèmes délirants sont polymorphes. Ce tableau clinique peut rester isolé, récidiver de façon épisodique ou représenter la manifestation inaugurale d'une schizophrénie chronique (expérience délirante primaire).

PSYCHOSE HALLUCINATOIRE CHRONIQUE : Variété de délire chronique, individualisée par l'école française et caractérisée par :

- l'absence de dissociation ;
- l'importance des manifestations hallucinatoires
- une relative systématisation des thèmes délirants
- une conservation prolongée de l'insertion sociale.

p. 382-383

PSYCHOSE MANIACO-DÉPRESSIVE : Variété de psychose fonctionnelle chronique caractérisée par des troubles de l'humeur : manie, mélancolie ou état mixte (voir ces mots). Les accès psychotiques sont séparés par des intervalles où le psychisme redevient normal. Dans la forme bipolaire de l'affection, les accès maniaques et mélancoliques alternent le plus souvent de façon irrégulière. Les formes unipolaires sont plus fréquentes. Il s'agit surtout de mélancolies intermittentes.

PSYCHOSOMATIQUE (Symptôme) : Ces symptômes psychophysiologiques sont des troubles somatiques divers que l'on rattache à la pathologie des émotions. Contrairement à l'émotion normale qui comprend un versant somatique avec des manifestations fonctionnelles passagères, dans la pathologie psychosomatique, les effets somatiques des émotions ne s'épuisent pas, persistent et peuvent engendrer des troubles organiques irréversibles.

PSYCHO-SYNDROME ORGANIQUE : Syndrome associant des troubles de la mémoire (amnésie rétrograde), des troubles de l'affectivité (incontinence affective), et des troubles de l'intelligence (perte des capacités de raisonnement abstrait). Ce syndrome témoigne d'une atteinte cérébrale diffuse lente, quelle que soit son étiologie. Il évolue vers un tableau de démence confirmée.

RAPTUS : Impulsion soudaine, invincible, qui pousse à commettre des actes irréfléchis hétéro-agressifs (meurtre) ou auto-agressifs (suicide par raptus anxieux).

RATIONALISME MORBIDE : Activité psychique qui consiste à fixer son attention et à exercer son raisonnement sur des contenus exclusivement abstraits, illogiques, autistiques, sans référence à des situations concrètes (fonctionnement à vide). Ce symptôme est considéré comme un élément séméiologique fondamental de certaines schizophrénies.

RÉACTION PATHOLOGIQUE : La pathologie « réactionnelle » regroupe divers symptômes qui apparaissent à la suite d'un traumatisme psychologique et qui demeurent en rapport direct et compréhensible avec ce traumatisme. Dans certains cas, l'événement déclenchant est majeur (deuil, catastrophe, abandon) ; ailleurs, le traumatisme paraît objectivement minime, mais l'événement vécu s'avère pathogène en raison d'une fragilité psychologique particulière (cf. : les personnalités pathologiques). Les troubles réactionnels peuvent réaliser un tableau de psychose ou de névrose (états confuso-anxieux ou confuso-délirants, réactions paranoïaques, réactions hystéro-anxieuses, réactions dépressives ou dépressions réactionnelles).

RITE, RITUEL (obsessionnel) : Stratagème utilisé par l'obsédé pour lutter contre ses obsessions. Les rites ont une valeur conjuratoire. Par exemple, des rites de lavage interminables sont déclenchés par la peur obsédante de la saleté ou des microbes ; ailleurs, la crainte d'une situation quelconque entraîne une tentative de conjuration par des ri-

tes les plus divers : rites d'habillage, compulsions à compter (arithmomanie), rites de vérification. Voir Compulsion et Obsession.

SCHIZOPHRÉNIE : Groupe de psychoses d'étiologie inconnue (psychoses fonctionnelles) se caractérisant par des troubles de la pensée, de l'affectivité et du comportement.

A la suite de Bleuler, on distingue :

- des symptômes fondamentaux : dissociation de la personnalité avec des troubles idéiques : troubles des associations, bizarreries, et des troubles affectifs : retrait, ambivalence, autisme ;
- des symptômes accessoires : hallucinations, idées délirantes, symptômes catatoniques, symptômes névrotiques et troubles du comportement.

Les formes cliniques habituellement décrites sont :

- une forme « simple » ;
- l'hébéphrénie, de début précoce, caractérisée par les symptômes fondamentaux ;
- une forme paranoïde avec syndrome délirant flou ;
- une forme catatonique ;
- des formes pseudo-névrotiques et pseudo-psychopathiques ;
- des formes dysthymiques.

SCHIZOTHYMIE : Humeur particulière, peu mobile, froide et distante. Les sujets schizothymes sont peu sociables et peu communicatifs.

SIDÉRATION : Anéantissement subit des forces vitales avec, au maximum, arrêt respiratoire et état de mort apparente. Par extension, inhibition motrice extrême, liée à une émotion violente, qui rend toute réaction motrice (fuite notamment) impossible.

SIGNE DE BABINSKI : Extension du gros orteil sous l'influence de l'excitation de la plante du pied qui, normalement, en provoque la flexion. Ce signe neurologique fondamental témoigne d'une lésion du faisceau pyramidal (voies cortico-spinales de la motricité volontaire).

SINISTROSE : Syndrome post-traumatique associant des idées de préjudice, des revendications et des interprétations erronées.

SITIOPHOBIE : Conduite délirante de refus alimentaire.

STÉRÉOTYPIES : Actes, gestes ou paroles répétitifs. On parle de stéréotypies verbales et gestuelles pour désigner ces troubles qui témoignent d'un trouble du cours de la pensée au cours des schizophrénies, des démences ou des oligophrénies.

SYNDROME PSEUDO-BULBAIRE : Ce syndrome comprend une démarche à petits pas, un rire et un pleurer spasmodiques, des troubles de la parole et de la déglutition. Il s'observe au cours de certaines atteintes vasculaires, en particulier la démence artériopathique.

SYNTONIE : Accord affectif étroit entre la personne et le monde environnant.

TACHYPHÉMIE Accélération de la production verbale avec logorrhée, parfois incoercible.

p. 384-385

TEST MENTAL Situation expérimentale standardisée qui sert de stimulus à un comportement. La conduite observée est évaluée par comparaison statistique avec celle d'autres individus placés dans une situation identique (groupe de référence ou étalon). La comparaison permet ainsi de « classer le sujet examiné soit quantitativement, soit typologiquement » (P. Pichot). On distingue les tests d'efficiences qui explorent les as-

pects cognitifs de la personnalité (intelligence, aptitudes verbales ou manipulatoires de performances diverses, connaissances) et les tests de personnalité qui explorent la dimension affective de l'individu (les tests les plus employés dans ce domaine étant certains questionnaires de personnalité — exploration analytique — et les tests « projectifs » — exploration synthétique).

TEST PROJECTIF : Variété de test mental permettant une exploration globale (perspective holistique) de la personnalité (exploration synthétique). Le matériel du test (faiblement ou non structuré) doit permettre le plus grand nombre de réponses possibles, les réponses du sujet examiné dépendent alors de sa personnalité globale dans la mesure où la structuration qu'il aura appliquée au stimulus traduit sa façon propre de structurer le monde. Les tests projectifs les plus fréquemment employés chez l'adulte sont le test des taches d'encre de H. Rorschach et le T.A.T. (Thematic Apperception Test).

TOXICOMANIE : Appétence particulière pour certaines drogues ou substances toxiques. La conduite toxicomane implique un besoin invincible, une tendance à augmenter les doses (tolérance) et une dépendance psychique et parfois physique.

Les toxicomanies majeures (opium et ses alcaloïdes, morphine, héroïne ou produits de synthèse) aboutissent à une déchéance progressive intellectuelle, affective et somatique.

Les toxicomanies mineures (substances psychotropes diverses, préparations de chanvre indien, psychodysléptiques tel le lysergamide ou L.S.D.) sont plus fréquentes. L'utilisation conjointe de plusieurs toxiques associés au café, au tabac ou à l'alcool (polytoxicomanies) facilite le déclenchement d'épisodes confuso-oniriques, d'exaltation de l'humeur, de psychoses aiguës, hallucinatoires ou non ; elle favorise surtout l'aggravation d'un état psycho pathologique antérieur.

L'emploi de ce terme est désormais déconseillé. On lui préfère celui de pharmacodépendance (O.M.S.) ou ceux d'abus ou de dépendance à des substances toxiques (D.S.M. III, 1980).

UNCINÉE (Crise) : Phénomène paroxystique de nature épileptique qui traduit une souffrance temporelle localisée (uncus de l'hippocampe). La crise uncinée se traduit par des hallucinations, souvent multisensorielles, et par un trouble de la conscience qui revêt soit l'aspect d'une absence (voir ce mot), soit celui d'un état de rêve (dreamy state), soit des sentiments de « déjà vu », ou, au contraire, « de jamais vu » ou de « jamais entendu ».

B. Classification française des troubles mentaux de l'enfant et de l'adolescent (révision 2012)

Extraits d'après Roger Misès (dir.) et al., *Classification française des troubles mentaux de l'enfant et de l'adolescent R-2012 : Correspondances et transcodage - CIM10*, Rennes, Presses de l'EHESP publique, 2012.

Axe 1 général : catégories cliniques de base

1. *Troubles envahissants du développement (TED), schizophrénies, troubles psychotiques de l'enfance et de l'adolescence*
 - 1.0 Autisme et troubles envahissants du développement (TED)
 - 1.00 Autisme infantile précoce – type Kanner
 - 1.01 Autres formes de l'autisme
 - 1.02 Autisme ou TED avec retard mental précoce
 - 1.03 Syndrome d'Asperger
 - 1.04 Dysharmonies multiples et complexes du développement, dysharmonies psychotiques
 - 1.05 Troubles désintégratifs de l'enfance
 - 1.08 Autres TED
 - 1.09 TED non spécifiés (NS)
 - 1.1 Schizophrénies
 - 1.10 Schizophrénie de l'enfant
 - 1.11 Troubles schizophréniques à l'adolescence
 - 1.2 Troubles délirants persistants
 - 1.3 Troubles psychotiques aigus
 - 1.30 Trouble psychotique aigu polymorphe sans symptômes schizophréniques
 - 1.31 Trouble psychotique aigu polymorphe avec symptômes schizophréniques
 - 1.38 Autres
 - 1.4 Troubles thymiques
 - 1.40 TED dysthymiques de l'enfant
 - 1.41 Troubles thymiques de l'adolescent
 - 1.410 Épisode maniaque (EM)
 - 1.4100 Épisode maniaque actuel s'inscrivant dans un trouble affectif bipolaire
 - 1.4101 Épisode maniaque sans symptômes psychotiques
 - 1.4102 EM avec symptômes psychotiques
 - 1.4103 État mixte
 - 1.4104 Hypomanie
 - 1.411 Épisode dépressif (ED)
 - 1.4110 Épisode dépressif actuel s'inscrivant dans un trouble affectif bipolaire
 - 1.4111 Épisode dépressif sévère sans dimension mélancolique manifeste
 - 1.4112 Épisode dépressif sévère sans dimension mélancolique manifeste, avec symptômes psychotiques
 - 1.4113 Épisode dépressif sévère avec dimension mélancolique
 - 1.4114 Épisode dépressif sévère avec mélancolie délirante
 - 1.6 États dépressifs après épisode psychotique

- 1.8 Autres troubles psychotiques
- 1.9 Troubles psychotiques non spécifiés
- 2. *Troubles névrotiques*
 - 2.1 TN à dominante anxieuse
 - 2.2 TN à dominante hystérique
 - 2.3 TN à dominante phobique
 - 2.4 TN à dominante obsessionnelle et compulsive
 - 2.5 TN avec prédominance des inhibitions
 - 2.6 Dépression névrotique
 - 2.7 Caractère névrotique, pathologie névrotiques de la personnalité
 - 2.8 TN avec perturbations prédominantes des fonctions instrumentales
 - 2.9 TN à expression plurimodale
 - 2.10 Troubles névrotiques NS
- 3. *Pathologies limites*
 - 3.0 Dysharmonies évolutives
 - 3.1 Pathologie limite avec prédominance des troubles de la personnalité
 - 3.2 Pathologie limite avec prédominance schizotypique
 - 3.3 Pathologie limite à prédominance comportementale
 - 3.4 Dépression liées à une pathologie limite
 - 3.8 Autres pathologie limite
 - 3.9 Pathologie limite NS
- 4. *Troubles réactionnels*
 - 4.0 Dépression réactionnelle
 - 4.1 Manifestations réactionnelles
 - 4.2 Syndrome de stress post-traumatique
- 0. *Variations de la normale*
 - 0.1 Angoisses, rituels, peurs
 - 0.2 Moments dépressifs
 - 0.3 Conduites d'opposition
 - 0.4 Conduites d'isolement
 - 0.5 Difficultés scolaires non classable ailleurs
 - 0.6 Retards ou régressions transitoires
 - 0.7 Aspects originaux de la personnalité
 - 0.8 Autres
 - 0.9 NS
- 6.0. *Troubles du développement et des fonctions instrumentales*
 - 6.01 Troubles de la parole et du langage
 - 6.01 Troubles isolés de l'articulation
 - 6.01 Troubles du développement du langage
 - 6.010 Retard de parole

- 6.011 Retard simple de langage
- 6.012 Dysphasie
- 6.018 Autres troubles du développement du langage
- 6.02 Aphasie acquise
 - 6.020 Aphasie acquise avec épilepsie, syndrome de Landau-Kleffner
 - 6.028 Autres aphasies acquises
- 6.03 Mutisme
 - 6.030 Mutisme total
 - 6.031 Mutisme sélectif
- 6.04 Bégaiement
- 6.08 Autres troubles de la parole et du langage
- 6.09 Troubles de la parole et du langage NS
- 6.1 *Troubles cognitifs et des acquisitions scolaires*
 - 6.10 Troubles lexicographiques
 - 6.100 Dyslexie isolée
 - 6.101 Troubles de l'orthographe isolé
 - 6.108 Autres troubles lexicographiques
 - 6.11 Troubles spécifiques de l'arithmétique (dyscalculie)
 - 6.12 Troubles du raisonnement (dysharmonies cognitives)
 - 6.13 Troubles de l'attention sans hyperkinésie
 - 6.18 Autres troubles cognitifs & des acquis scolaires
 - 6.19 Troubles cognitifs & des acquis scolaires NS
- 6.2 *Troubles psychomoteurs*
 - 6.20 Retard psychomoteur (troubles spécifiques du développement moteur)
 - 6.21 Tics
 - 6.210 Tics isolé
 - 6.211 Tic moteur ou vocal chronique
 - 6.212 Maladie de Gilles de la Tourette
 - 6.28 Autres troubles psychomoteurs
 - 6.29 Troubles psychomoteurs NS
- 7. *Troubles des conduites et des comportements*
 - 7.0 Troubles hyperkinétiques
 - 7.00 Hyperkinésie avec troubles de l'attention, troubles déficit de l'attention avec hyperactivité (TDAH)
 - 7.08 Autres troubles hyperkinétiques
 - 7.09 Troubles hyperkinétiques NS
 - 7.1 Troubles des conduites alimentaires
 - 7.10 Anorexie mentale
 - 7.100 Anorexie mentale restrictive
 - 7.101 Anorexie mentale boulimique
 - 7.11 Anorexie mentale atypique

- 7.12 Boulimie
- 7.13 Boulimie atypique
- 7.14 Troubles des conduites alimentaires du nourrisson et de l'enfant
- 7.15 Troubles alimentaires du nouveau-né
- 7.18 Autres troubles des conduites alimentaires
- 7.19 Troubles des conduites alimentaires NS
- 7.2 Conduites suicidaires
- 7.3 Troubles liés à l'usage de drogues ou alcool
 - 7.3 x 0 Alcool
 - 7.3 x 1 Morphiniques
 - 7.3 x 2 Cannabis
 - 7.3 x 3 Hypnotiques et tranquillisants
 - 7.3 x 4 Cocaïne
 - 7.3 x 5 Autres psychostimulants et dysléptiques dont caféine, amphétamines, ecstasy, LSD
 - 7.3 x 6 Hallucinogènes
 - 7.3 x 7 Tabac
 - 7.3 x 8 Solvants volatils
 - 7.3 x 9 Polytoxicomanies, autres substances psychoactives
- 7.30 x Intoxication aiguë
- 7.31 x Utilisation nocive pour la santé
- 7.32 x Syndrome de dépendance
- 7.33 x Syndrome de sevrage
- 7.34 x Syndrome de sevrage avec délirium
- 7.35 x Trouble psychotique
- 7.36 x Syndrome amnésique
- 7.37 x Trouble résiduel ou psychotique tardif
- 7.38 x Autres troubles mentaux et du comportement
- 7.39 x Trouble mental ou du comportement NS
- 7.4 Troubles de l'angoisse de séparation
- 7.5 Troubles de l'identité et des conduites sexuelles
- 7.50 Troubles de l'identité sexuelle
- 7.51 Troubles de la préférence sexuelle
- 7.52 Manifestations en rapport avec des préoccupations excessives concernant le développement sexuel et son orientation
- 7.58 Autres troubles des conduites sexuelles
- 7.59 Troubles des conduites sexuelles NS
- 7.7 Autres troubles caractérisés des conduites
 - 7.70 Pyromanie
 - 7.71 Kleptomanie
 - 7.72 Trichotillomanie
 - 7.73 Fugues
 - 7.74 Violence contre les personnes
 - 7.75 Conduites à risques

- 7.76 Errance
- 7.78 Autres troubles caractérisés des conduites
- 7.8 Autres troubles des conduites
- 7.9 Troubles des conduites et des comportements NS
- 8 *Troubles à expression somatique*
 - 8.0 Affections psychosomatiques
 - 8.1 Troubles psychofonctionnels
 - 8.2 Troubles hypocondriaques
 - 8.3 Énurésie
 - 8.4 Encoprésie
 - 8.5 Trouble du sommeil
 - 8.6 Retard de croissance psychogène
 - 8.8 Autres troubles à expression somatiques
 - 8.9 Trouble à expression somatique NS
- 9 *Manifestations et symptômes à type d'anxiété, de phobie, de conversion, de compulsion*
 - 9.0 Symptômes anxieux
 - 9.00 Attaques de panique
 - 9.01 Anxiété généralisée
 - 9.02 Angoisse de séparation
 - 9.08 Autres manifestations anxieuses
 - 9.1 Symptômes conversifs
 - 9.10 Symptômes moteurs de conversion
 - 9.11 Symptômes sensoriels de conversion
 - 9.12 Multiples symptômes de conversion
 - 9.18 Autres symptômes de conversion
 - 9.2 Symptômes phobiques
 - 9.20 Avec symptômes agoraphobiques
 - 9.200 Agoraphobie sans trouble panique
 - 9.201 Agoraphobie avec trouble panique
 - 9.21 Phobies sociales
 - 9.22 Phobies scolaires
 - 9.23 Phobies spécifiques (isolées)
 - 9.24 Dismorphophobie
 - 9.28 Autres symptômes phobiques
 - 9.3 Manifestations obsessionnelles et compulsives
 - 9.30 TOC. idées obsédantes au premier plan
 - 9.31 TOC. rituels compulsifs au premier plan
 - 9.32 TOC. forme mixte
 - 9.38 Autres TOC

Axe 2 : personnalités

Facteurs intérieurs et associés :

- Facteurs organiques (maladie d'origine génétique).
- Facteurs renvoyant aux conditions d'environnement, tels que la carence affective, éducative, sociale et culturelle ainsi que les mauvais traitements et les négligences.

Les troubles de la personnalité représentent une « modalité durable de l'expérience vécue et des conduites qui dévie notablement de ce qui est attendu dans la culture de l'individu. »

Dix troubles de la personnalité sont diagnostiqués selon que prédominent tel ou tel trait de personnalité (trait de caractère, type de comportement, attitudes interactionnelles).

Personnalité :

1. Paranoïaque
2. Schizoïde (manque d'intérêt pour les relations sociales)
3. Schizotypique (faiblesse de la capacité motivante du plaisir)
4. Antisociale
5. Borderline (profondeur et la variabilité des émotions)
6. Histrionique
7. Narcissique
8. Évitante
9. Dépendante
10. NS (non spécifique)

C. Mécanismes de défense

La liste des mécanismes, voire parfois leur description, est variable selon les auteurs. Les définitions proposées ci-dessous sont reprises de Ionescu Serban., Jacquet Marie-Madeleine, Lhote Claude, *Les mécanismes de défense. Théorie et clinique*, Paris, Dunod, 2020.

1. Activisme

« Gestion des conflits psychiques, ou des traumatismes externes, par le recours à l'action, à la place de la réflexion ou du vécu des affects »

2. Affiliation

« Recherche de l'aide et du soutien d'autrui quand on vit une situation qui engendre de l'angoisse »

3. Affirmation de soi par l'expression des sentiments / assertivité

« En proie à un conflit émotionnel ou à un événement extérieur stressant, la personne qui utilise ce mécanisme de défense communique sans détour sentiments et pensée, d'une façon qui n'est ni agressive ni manipulatrice »

4. Altruisme

« Dévouement à autrui qui permet au sujet d'échapper à un conflit »

5. Annulation rétroactive

« Illusion selon laquelle il serait possible d'annihiler un événement, une action, un souhait, porteurs de conflits, grâce à la toute-puissance d'une action ou d'un souhait ultérieur, censés avoir un effet de destruction rétroactive »

6. Anticipation

« Anticiper consiste, lors d'une situation conflictuelle, à imaginer l'avenir :
- en expérimentant d'avance ses propres réactions émotionnelles
- en prévoyant les conséquences de ce qui pourrait arriver
- en envisageant différentes réponses ou solutions possibles »

7. Ascétisme de l'adolescent

« Refus par l'adolescent de toutes les jouissances corporelles, même les plus innocentes. Ce mécanisme de défense est destiné à protéger le Moi contre les exigences pulsionnelles nouvelles qui sont sources d'angoisse »

8. Clivage (du moi, de l'objet)

« Action de séparation, de division du Moi (clivage du Moi) ou de l'objet (clivage de l'objet) sous l'influence angoissante d'une menace, de façon à faire coexister les deux parties ainsi séparées qui se méconnaissent sans formation de compromis possible »

9. Contre- investissement

« Energie psychique du Moi qui s'oppose à la tendance à la décharge de la pulsion. Force inconsciente contraire et au moins égale à celle qui, en provenance du ça, cherche à parvenir à la conscience »

10. (Dé)néigation

« Dans l'œuvre de Freud, le terme dénégation recouvre les deux sens suivants :
- refus de reconnaître comme siens, immédiatement après les avoir formulés, une pensée, un désir, un sentiment qui sont sources de conflit
- refus par le sujet d'une interprétation exacte le concernant, formulée par un interlocuteur (habituellement un psychanalyste). »

11. Dén

« Action de refuser la réalité d'une perception vécue comme dangereuse ou douloureuse pour le Moi »

12. Formation réactionnelle

« Transformation du caractère permettant une économie du refoulement, puisqu'à des tendances inacceptables sont substituées des tendances opposées, qui deviennent permanentes. »

13. Humour

« Au sens restreint retenu par Freud, l'humour consiste à présenter une situation vécue comme traumatisante de manière à en dégager les aspects plaisants, ironiques, insolites. C'est dans ce cas seulement (humour appliqué à soi-même) qu'il peut être considéré comme un mécanisme de défense »

14. Identification

« Assimilation inconsciente, sous l'effet du plaisir libidinal et/ou de l'angoisse, d'un aspect, d'une propriété, d'un attribut de l'autre, qui conduit le sujet, par similitude réelle ou imaginaire, à une transformation totale ou partielle sur le modèle de celui auquel il s'identifie. L'identification est un mode de relation au monde constitutif de l'identité »

15. Identification à l'agresseur

« Ce mécanisme désigne le fait qu'un sujet, confronté à un danger extérieur, s'identifie à son agresseur selon différentes modalités :

- soit en reprenant à son compte l'agression telle quelle
- soit en imitant physiquement ou moralement la personne de l'agresseur
- soit en adoptant certains symboles de puissance qui le caractérisent »

16. Identification projective

« Mécanisme consistant en un fantasme dans lequel le sujet imagine s'introduire partiellement à l'intérieur de l'autre, tentant ainsi de se débarrasser de sentiments, de pulsions ressenties comme indésirables, et cherchant de cette façon à nuire, à posséder et à contrôler cette autre personne. »

17. Intellectualisation

« Recours à l'abstraction et à la généralisation face à une situation conflictuelle qui angoisserait trop le sujet s'il reconnaissait y être personnellement impliqué »

18. Introjection

« Inclusion fantasmatique - de l'objet, d'une partie de celui-ci ou du lien à ce dernier – qui sert de repère au Moi pour l'appréhension de l'objet extérieur dont le détachement est alors possible »

19. Isolation

« Le terme isolation recouvre deux sens. Il peut désigner :

- une élimination de l'affect lié à une représentation (souvenir, idée, pensée) conflictuelle, alors que la représentation en question reste consciente
- une séparation artificielle entre deux pensées ou deux comportements qui en réalité sont liés, leur relation ne pouvant être reconnue sans angoisse par la personne »

20. Mise à l'écart / rejet

« Tentative de rejet volontaire, hors du champ de la conscience, de problèmes, désirs, sentiments ou expériences qui tourmentent ou inquiètent un sujet »

21. Projection

« Opération par laquelle le sujet expulse dans le monde extérieur des pensées, affects, désirs qu'il méconnaît ou refuse en lui et qu'il attribue à d'autres, personnes ou choses de son environnement »

22. Rationalisation

« Justification logique, mais artificielle, qui camoufle, à l'insu de celui qui l'utilise, les vrais motifs (irrationnels et inconscients) de certains de ces jugements, de ses conduites, car ses motifs véritables ne pourraient être reconnus sans anxiété »

23. Refoulement

« Rejet dans l'inconscient de représentations conflictuelles qui demeurent actives, tout en étant inaccessibles à la prise de conscience. Le retour du refoulé, dont les conséquences peuvent être anodines ou pathologiques, intervient en cas d'échec ou d'insuffisance du refoulement »

24. Refuge dans la rêverie (fantasmatisation)

« Mécanisme qui consiste en un recours – dans une situation de conflit psychique ou lorsque le sujet est confronté à des facteurs stressants – à une rêverie diurne excessive se substituant à la poursuite de relations interpersonnelles »

25. Régression

« La régression constitue un retour - plus ou moins organisé et transitoire – à des modes d'expression antérieurs de la pensée, des conduites ou des relations objectales, face à un danger interne ou externe susceptible de provoquer un excès d'angoisse ou de frustration »

26. Renversement dans le contraire

« Mécanisme où une pulsion conflictuelle est non seulement refoulée, mais aussi remplacée par la pulsion opposée » (= refoulement + contre-investissement)

27. Retournement contre soi-même

« Refus inconscient par un sujet de sa propre agressivité, qu'il détourne d'autrui pour la reporter sur lui-même. Ce mécanisme de défense peut être à la source de sentiments de culpabilité, d'un besoin de punition, d'une névrose d'échec, de tentatives d'auto-destruction »

28. Retrait (apathique) / repli sur soi

« Détachement protecteur, fait d'indifférence affective, de restriction des relations sociales et des activités extérieures, et de soumission passive aux événements, qui permet à une personne de supporter une situation très difficile »

29. Sublimation

« Le terme sublimation a deux sens dans l'œuvre de Freud :

- désexualisation d'une pulsion s'adressant à une personne qui pourrait (ou qui a pu) être désirée sexuellement. La pulsion, transformée en tendresse ou amitié, change de but, mais son objet reste le même
- dérivation de l'énergie d'une pulsion sexuelle ou agressive vers des activités valorisées socialement (artistiques, intellectuelles, morales). La pulsion se détourne alors de son objet et de son but (érotique ou agressif) primitifs, sans être refoulée. C'est le sens le plus habituel »

Il est à noter que certains symptômes, qui sont à proprement parler la conséquence de l'action de mécanismes de défense, sont dans une proximité telle avec le processus sous-jacent que les deux sont presque indissociables et sont désignés par le même terme : c'est le cas notamment du "repli sur soi", "mise à l'écart", "activisme" "intellectualisation", etc.

D. Personnalités pathologiques

B.1. Principaux types

Personnalité paranoïaque

Méfiance soupçonneuse envahissante envers les autres dont les intentions sont interprétées comme malveillantes.

Personnalité schizoïde

Mode général de détachement social et affectif, de repli sur soi et de restriction de la variété des expressions émotionnelles dans les rapports avec autrui.

Personnalité antisociale

Mode général de transgression des droits d'autrui.

Personnalité borderline

Mode général d'instabilité relationnelle, affective, avec une impulsivité importante, une perturbation de l'identité (instabilité de l'image de soi).

Personnalité histrionique / hystérique

Mode général de réponses émotionnelles excessives, de quête d'attention.

Personnalité narcissique

Mode général de fantaisies ou comportements grandioses, besoin d'être admiré, manque d'empathie.

Personnalité évitante

Mode général d'inhibition social, de crainte d'être critiqué, de réticence à s'impliquer, de peur de ne pas être capable.

Personnalité dépendante

Mode général d'indécision, de besoin d'être pris en charge, de comportements soumis et adhésif.

Personnalité obsessionnelle

Mode général de préoccupation pour les détails, les règles, l'ordre, le perfectionnisme qui empêche l'achèvement des tâches.

Personnalité sensitive

Mode général de relatif isolement social et de méfiance, haute opinion de soi très intériorisée, asthénie, hypersensibilité susceptibilité, fatigabilité, rétention d'affects.

Personnalité psychasthénique

Mode général d'incapacité à agir, troubles attentionnels, insomnies, perte d'appétit, préoccupations obsédantes, anxiété chronique, doute permanent, ruminations, phobies et inhibitions.

B.2. Quelques descriptions détaillées

Personnalité hystérique / histrionique

Les principaux traits de personnalité sont les suivants (certains sont partagés avec la personnalité narcissique) :

- Labilité émotionnelle.
- Histrionisme (théâtralisme, dramatisation, multiplicité des rôles).
- Pauvreté et facticité des affects.
- Mythomanie (fabulations, inventions imaginaires, rêveries narcissiques).
- Avidité affective (avec intolérance aux frustrations).
- Comportements de séduction.
- Érotisation des rapports sociaux (souci de plaire et de se faire valoir).
- Décharges émotionnelles spectaculaires (« crises de nerf »).
- Dépendance affective (immaturité, provocations, importance primordiale du désir des autres...).
- Suggestibilité (sensibilité à l'hypnose).
- Troubles de la sexualité (frigidité, homosexualité, nymphomanie, inhibition).
- Troubles de la mémoire (falsification du vécu, amnésie lacunaire sélective, refoulements amnésiques, flou de la biographie).

Particularité chez l'homme :

- Moins bonne tolérance sociale que chez la femme.
- Association fréquente à des traits de psychopathie.
- Vantardise (afin de masquer ses manques).
- Don Juanisme et/ou éviction de la sexualité.

Risques évolutifs :

- Somatisations : grande appétence médicale.
- Dépression névrotique et/ou réactionnelle avec tentatives de suicide.

Personnalité anxio-phobique

Les traits de cette personnalité sont très proches de la névrose correspondante (névrose phobique), et de la personnalité évitante, et sont souvent associés à des traits hystériques et/ou obsessionnels.

Les principaux traits de personnalité sont les suivants :

- Hyper-émotivité (état d'alarme constant, rougeissements, lutte anxieuse et impuissante contre cet état).
- Fond anxieux permanent.
- Phobies sociales (peur de parler en public et/ou d'être « jugé » si l'on s'exprime).

- Inhibition (timidité, inhibitions sexuelles, effacement, blocages, refus des responsabilités, paresse, adynamisme).

Deux types de comportements caractéristiques :

- Conduites d'évitement (relations sociales...)
- Fuite manifeste devant une situation angoissante (voyages, ascenseurs, foule...).
- Réactions d'échec (repli et pessimisme).

Conduites de surcompensation :

- Défis (sports à haut risque).
- Fuites en avant.
- Affrontements des situations redoutées.
- Conduites de réassurance à minima : aménagement de conditions rendant l'angoisse supportable (présence d'une personne ou d'un objet contraphobique).

Personnalité obsessionnelle

La personnalité obsessionnelle est composée :

- D'un fond psychasthénique (P. Janet).
- Asthénie psychique et physique.
- Dépression chronique avec recours à des stimulants divers.
- Activité réduite et inefficace (quasi-apragmatisme) qui ne favorise pas l'adaptation sociale.
- Introspection anxieuse empêchant d'agir.
- Doutes et scrupules.
- Inhibition sociale et sexuelle.
- Stigmates psychomoteurs (« débilite motrice de Dupré » : tics, onychophagie, énurésie, trichotillomanie, vertiges...).
- D'un caractère sadique-anal (S. Freud) : caractère bien structuré se repérant facilement, mélange d'agressivité, d'analité et de formations réactionnelles.
- Érotisme anal et agressivité sadique :
- Obstination et perfectionnisme.
- Saleté.
- Collectionnisme, volonté de puissance.
- Souci exagéré de l'ordre.
- Lutte contre l'autorité.
- Parcimonie et avarice.
- Cynisme et sarcasmes.
- Angoisse de séparation.
- Cruauté.
- Formations réactionnelles :
- Prodigalité.
- Soumission.
- Témérité.

- Impossibilité de s'attacher.
- Surpropreté.
- Politesse obséquieuse.
- Obéissance.
- Douceur.
- Moralisme.
- Bonté et souci de justice.
- Recherche du mot exact.
- Intellectualisations.
- Absence d'inquiétude.

Risques évolutifs :

- Surtout sur un mode anxiodépressif.
- Association fréquente chez les colopathes et les coronariens.
- Chez l'adolescent : mode d'entrée possible dans un processus schizophrénique.

Personnalité paranoïaque

Les principaux traits de la personnalité paranoïaque sont les suivants :

- Psycho-rigidité (froideur, entêtement, rigidité des attitudes d'esprit et des raisonnements, « manichéisme », monolithisme des pensées).
- Méfiance (allant jusqu'à la réticence).
- Susceptibilité et rancœurs.
- Surestimation de soi et sous-estimation des autres.
- Orgueil démesuré (fausse modestie ou mépris affiché, sentiment d'être incompris et intolérance hostile vis-à-vis des autres).
- Autoritarisme tyrannique.
- Fausseté du jugement : assurance irrationnelle, pensée paralogique, interprétations erronées se mêlant à des degrés divers avec une défense contre le délire).
- Absence d'autocritique.
- Troubles des relations sociales (malgré un bon niveau intellectuel) : agressivité, conflits, réactions passionnelles inadaptées, intransigeance...
- Sthénicité variable.

Risques évolutifs :

- Plaintes hypocondriaques multiples, avec revendications, voire menaces et procès contre le(s) médecin(s) (cf. la sinistrose des « Délires chroniques »).
- Réactions passionnelles à des événements réels et/ou imaginaires (posent le problème d'un délire à minima) : jalousie, procès, rivalités, questions d'argent... Risque de passage à l'acte médico-légal.
- Effondrement dépressif rarissime (mais majeur avec risque de « suicide à plusieurs »).

Personnalité sensitive

La personnalité sensitive associe des traits de la personnalité paranoïaque et de la personnalité psychasthénique :

- Souffrance silencieuse, mais intense.

- Hyper-émotivité (sans décharge émotionnelle).
- Hyperesthésie dans les rapports avec les autres.
- Grande vulnérabilité.
- Dépression
- Asthénie.
- Pessimisme.
- Plaintes hypocondriaques avec revendication non sthénique.
- Sentiments d'échecs volontiers « projetés » sur les autres (qui en sont la « cause »).
- Autres traits paranoïaques : sténie, orgueil, froideur affective, mépris des autres, assurance, agressivité...
- Autres traits psychasthéniques : asthénie, sentiment d'échec, tristesse, introspection, scepticisme, indécision, timidité, hyperesthésie des contacts...

Personnalité psychopathique

Les termes de « déséquilibre psychopathique », de « sociopathie », de « psychopathie » sont à peu près équivalents et délimitent un type d'organisation pathologique de la personnalité caractérisé par une structure particulière (impulsivité + instabilité) et une forme de déviance sociale (surtout masculine et dans les milieux socio-familiaux désorganisés).

Les principaux traits de la personnalité psychopathique sont les suivants :

- Impulsivité majeure.
- Passages à l'acte hétéro et/ou auto-agressifs très fréquents.
- Manifestations caractérielles (colères, opposition, vécu persécutif).
- Immaturité.
- Tendance aux transgressions (conduites à risque, délinquance++).
- Difficulté à l'élaboration mentale.
- Incapacité à penser un affect désagréable : ennui et dysphorie.
- Angoisse agis (ce qui court-circuite l'insight) : malaise profond.
- Affectivité en apparence froide, avec absence d'une réelle capacité à la culpabilité.
- Une tendance à la mythomanie et à la manipulation.
- Traits de personnalité hystérique.
- Appétences toxicophiliques.
- Aménagements pervers.

Principaux risques évolutifs :

- État dépressif majeur, fréquent, souvent réactionnel : sentiments de vide, d'ennui, de rejet, de revendications.
- État d'agitation.
- Tentatives de suicides et équivalents suicidaires : très fréquents, répondant à des motivations complexes (appel, ordalie, fuite, provocation, impulsivité, agitation clastique...).
- Bouffée délirante aiguë. Psychoses carcérales. Surmortalité complication d'une toxicomanie et/ou d'un alcoolisme, accidents, infection à HIV.
- Délinquance.
- Vagabondage et clochardisation.

Personnalité schizoïde

Les principaux traits de la personnalité schizoïde sont les suivants :

- Attitude de repli avec désintérêt relatif pour le monde extérieur.
- Introversion.
- Sujet solitaire, rêveur et secret.
- Timidité froide.
- Contact distant chez un individu « terne » et effacé.
- Indifférence de surface (« hermétisme de façade ») masquant une hypersensibilité teintée d'ambivalence.
- Vie imaginaire cependant intense (+++), mais « bizarre » ésotérisme, idéalisme doctrinaire, préoccupations philosophiques, scientifiques et théologiques, mêlées à un certain degré de perte de contact avec la réalité.
- Rationalisation à la limite de la morbidité.
- Refuge dans un monde d'abstractions.
- Fuite des contacts sociaux non phobiques, accentuée par les déceptions et les frustrations.

Risques évolutifs :

- Mode d'entrée dans la schizophrénie.
- Possible adaptation sociale, toutefois restreinte.
- La désocialisation peut entraîner un repli douloureux avec dépression atypique et tentative de suicide.
- Des troubles des conduites alimentaires sont relativement fréquents.
- Un délire chronique peut s'organiser.

Sommaire

1. SIGNES ET SYMPTOMES

- 1.1. La structure théorique du symptôme
 - 1.2.1.1. *Du côté du sujet : les symptômes*
 - 1.2.1.2. *Du côté de l'observateur : les signes et syndromes*
 - 1.2.1.3. *Signe et sémiologie*
- 1.2. Le statut du symptôme dans les différentes psychopathologies
 - 1.2.2.1. *Les "dys-" : l'hyper-, l'hypo- et le para-*
 - 1.2.2.2. *L'exemple de la phobie*
- 1.3. Méthodologie de l'étude de cas (Mme V., 40 ans)

2. LES PRINCIPAUX SIGNES CLINIQUES

- 2.1. La pensée
 - a) *Le jugement et le raisonnement*
 - b) *Le cours de la pensée*
 - c) *Le contenu de la pensée*
 - d) *Les idées délirantes*
 - 1/ *Thèmes*
 - 2/ *Mécanismes*
 - 3/ *Degré de systématisation*
 - 4/ *Extension*
 - 5/ *Acuité ou chronicité*
 - 6/ *Degré de conviction*
- 2.2. L'humeur et les émotions
 - a) *L'expression des émotions*
 - b) *Les troubles de l'humeur*
 - c) *La peur et l'angoisse, les phobies*
- 2.3. La perception
 - a) *Les illusions*
 - b) *Les hallucinations*
 - 1/ *Les hallucinations psycho-sensorielles*
 - 2/ *Les hallucinations psychiques*
 - c) *La conscience de soi*
- 2.4. Le langage
 - a) *L'expression verbale*
 - b) *La sémantique et la syntaxe*
 - c) *La dyslexie*
 - d) *Les aphasies*
- 2.5. La mémoire

- a) *Les amnésies*
- b) *Les libérations mnésiques*
- c) *Les paramnésies (illusions de mémoire)*
- 2.6. *L'intelligence*
- 2.7. *La conscience*
 - a) *La vigilance*
 - b) *L'attention*
- 2.8. *L'activité (psychomotrice)*
 - a) *Les déficits*
 - b) *L'agitation*
 - c) *Les impulsions*
 - d) *Les apraxies*
- 2.9. *Les conduites*
 - a) *La présentation*
 - b) *Les mimiques*
 - c) *Le sommeil*
 - d) *L'alimentation*
 - e) *Les sphincters*
 - f) *La sexualité*
 - g) *Les rituels*
 - h) *Les transgressions*

3. CATEGORIES ET STRUCTURES

- 3.1. Les classifications sémiologiques
 - 3.1.1. *Les catégorisations*
 - 3.1.2. *Les syndromes*
 - 3.1.3. *Les tableaux cliniques*
- 3.2. Les entités psychopathologiques
 - 3.2.1. *Nosographie et nosologie*
 - 3.2.2. *Les entités psychiatriques et psychopathologiques*
 - 3.2.2.1. *Les regroupements traditionnels*
 - 3.2.2.2. *Déplacement nosographique et analyse transnosographique*
 - 3.2.3. *Les classifications psychanalytiques*
- 3.3. Structure, personnalités et pathologies
 - 3.3.1. *La notion de structure*
 - 3.3.1.1. *La structure psychique*
 - 3.3.1.2. *Les processus mentaux*
 - 3.3.2. *Structure et personnalité pathologique*

BIBLIOGRAPHIE

ANNEXES

- A. Lexique abrégé (Samuel-Lajeunesse, Guelfi)
- B. Classification française des troubles mentaux de l'enfant et de l'adolescent (révision 2012)

Axe 1 général : catégories cliniques de base

Axe 2 : personnalités

C. Mécanismes de défense

1. Activisme
2. Affiliation
3. Affirmation de soi par l'expression des sentiments / assertivité
4. Altruisme
5. Annulation rétroactive
6. Anticipation
7. Ascétisme de l'adolescent
8. Clivage (du moi, de l'objet)
9. Contre- investissement
10. (Dé)négation
11. Dénî
12. Formation réactionnelle
13. Humour
14. Identification
15. Identification à l'agresseur
16. Identification projective
17. Intellectualisation
18. Introjection
19. Isolation
20. Mise à l'écart / rejet
21. Projection
22. Rationalisation
23. Refoulement
24. Refuge dans la rêverie (fantasmatisation)
25. Régression
26. Renversement dans le contraire
27. Retournement contre soi-même
28. Retrait (apathique) / repli sur soi
29. Sublimation

D. Personnalités pathologiques

B.1. Principaux types

Personnalité paranoïaque
Personnalité schizoïde
Personnalité antisociale
Personnalité borderline
Personnalité histrionique / hystérique
Personnalité narcissique
Personnalité évitante
Personnalité dépendante

Personnalité obsessionnelle
Personnalité sensitive
Personnalité psychasthénique

B.2. Quelques descriptions détaillées

Personnalité hystérique / histrionique
Personnalité anxio-phobique
Personnalité obsessionnelle
Personnalité paranoïaque
Personnalité sensitive
Personnalité psychopathique
Personnalité schizoïde

SOMMAIRE